

我国社会医学的基本任务

- 1.倡导积极的健康观和现代医学模式强调健康的社会决定因素
- 2.改善社会卫生状况，提高人群健康水平。
- 3.制订社会卫生策略和措施：为相关部门开展政策研究，从事决策分析，以及制订区域卫生规划等提供理论基础和方法学指导。
- 4.开展健康弱势人群保健和社会病控制

1.1 社会医学概述



[概念] 概念释义：社会医学（Social Medicine）是研究社会因素与健康及疾病之间相互联系及其规律的一门科学，是医学与社会学、经济学、管理学等社会科学相互渗透融合形成的一门交叉学科。它从社会宏观视角出发，研究社会因素对人群健康的影响，探讨保障人群健康的社会策略和方法。

1.1.1 社会医学的研究对象

特别是高危人群(处于高危状态下的人群，如老人、儿童、妇女、残疾者、有害作业职工、流动人口等)

社会医学以**社会人群的健康**为研究对象，主要关注：

1. **社会因素与人群健康的相互作用关系**——研究社会政治、经济、文化、行为、环境等因素对人群健康的影响
2. **社会卫生状况及人群健康状况**——评价和描述人群健康状况及其变动规律
3. **改善社会卫生状况的策略与措施**——提出保护人群健康、提高健康水平的社会卫生对策
4. **社会医学研究方法**——运用社会学、流行病学、统计学等多学科方法开展研究

1.1.2 社会医学的研究内容

社会医学的三大研究内容

1. **研究社会卫生状况**——主要是人群健康状况。通过社会卫生调查，评价人群健康水平及其变动规律，发现主要社会卫生问题及高危人群。核心指标包括：死亡率、发病率、期望寿命、伤残调整寿命年（DALY）等。
2. **研究影响人群健康的因素**——特别是社会制度、经济状况、文化因素、人口发展、生活劳动条件、行为生活方式及卫生服务等社会因素对健康的影响。揭示社会因素与健康之间的因果关系及其强度。
3. **研究社会卫生策略与措施**——针对已发现的社会卫生问题及其原因，制定并实施有效的社会卫生策略与措施，包括卫生政策、卫生规划、卫生服务体系改革、健康促进等。

- ！重点掌握：**社会医学与预防医学、社区医学、卫生管理学、医学社会学等学科既有联系又有区别：
- 预防医学侧重于生物、物理、化学因素对健康的影响及其预防
 - 社会医学侧重于社会因素对健康的影响及社会性防治策略
 - 社区医学侧重于社区范围内的卫生服务和健康管理
 - 卫生管理学侧重于卫生系统的组织、管理和政策实施
 - 医学社会学从社会学角度研究医学现象、医疗组织和医患关系

1.2 社会医学的任务

社会医学的基本任务

- 掌握社会卫生状况及人群健康状况
 - 发现主要的社会卫生问题及其影响因素
 - 提出改善社会卫生状况即促进人群健康状况的 策略和措施
- 确定卫生工作重点，合理配置卫生资源，科学组织卫生服务，加强卫生监督和评价。

1.3 社会医学的发展历程

1.3.1 国外社会医学发展

表 1.1: 社会医学发展史上的重要人物与贡献

人物/时期	主要贡献
古希腊时期	希波克拉底（Hippocrates）提出环境与健康的关系，关注空气、水、土壤和居住条件对健康的影响
18-19 世纪	工业革命时期，城市化带来严重公共卫生问题，推动卫生改革运动
法国 Rochoux（1838）	首次提出“社会医学”概念
法国 Guérin（1848）	将社会医学分为社会生理学、社会病理学、社会卫生学、社会治疗学四部分
德国 Neumann（1813-1908）	强调“医学是一门社会科学”，健康是社会问题
德国 Virchow（1821-1902）	提出“医学科学的核心是社会科学”、“政治是更大范围的医学”，开展斑疹伤寒调查
德国 Grotjahn（1869-1931）	现代实验社会医学奠基人，1920 年创办柏林大学社会卫生学系
英国 19 世纪	Chadwick 推动公共卫生法案；Simon 开展社会卫生调查
WHO（1948 起）	提出健康定义；推动“人人享有卫生保健”全球战略（1978，Alma-Ata 宣言）

！重点掌握：社会医学发展的三个时期：

1. 萌芽期（19 世纪以前）：以临床医学和环境卫生学为基础，关注环境与疾病的关系
2. 创立期（19 世纪）：社会医学概念正式提出，卫生改革运动兴起，关注社会因素对人群健康的影响
3. 发展期（20 世纪至今）：社会医学成为独立学科，进入大学教育体系，WHO 推动全球卫生战略

1.3.2 我国社会医学发展

1. 古代：中医经典《黄帝内经》即重视环境、情志与社会因素对人体健康的影响，体现“天人合一”的整体医学思想
2. 近代（20 世纪初）：1910 年设立卫生检疫机构；1922 年《社会医学》概念传入中国；1941 年陈志潜等在河北定县开展农村卫生实验区，创建“定县模式”，被誉为“中国社区医学之父”
3. 新中国成立后（1949-）：1952 年设立卫生系，开展社会卫生教学；引进苏联保健组织学；开展爱国卫生运动
4. 改革开放后（1980-）：1980 年卫生部发布《关于加强社会医学与卫生管理学教学科研工作的通知》；1984 年第一本《社会医学》教材出版；各医学院校设立社会医学教研室
5. 21 世纪以来：社会医学与卫生事业管理学科蓬勃发展；健康中国战略实施；社区卫生服务和全科医学快速发展

1.4 社会医学的特色理论与创新观点

1.卫生事业与社会协调发现;2.健康与社会经济发展的双向作用;3.生理、心理和社会的健康观;4.高危人群和高危因素;5.疾病防治中社会因素的决定作用;6.全社会参与的大卫生观。

社会医学的特色理论

1. 社会健康观——健康不仅是生物学现象，更是社会现象。人群健康水平受到政治、经济、文化、环境等社会因素的综合影响
2. 社会因素决定论——社会因素是影响人群健康的根本原因，生物因素和行为因素受社会因素制约
3. 健康公平理论——关注不同社会阶层、地区、人群之间健康水平的差异，强调社会公正和健康公平
4. 整体健康观——健康是社会、心理、生物因素相互作用的综合体现，需从多维度认识健康
5. 大卫生观——健康不仅是卫生部门的责任，需要全社会参与，强调跨部门协作
6. 健康社会决定因素理论——WHO 倡导的健康社会决定因素框架，强调“从根源上解决健康不公平”

！重点掌握：社会医学的创新观点：

- 将健康融入所有政策（HiAP）：健康不仅是卫生部门的职责，所有公共政策都应考虑对健康的影响
- 健康共治：政府、社会、个人共同参与健康治理
- 全生命周期健康管理：从出生到死亡的全过程健康维护

2.1 医学模式的概念

[概念] 概念释义：医学模式（Medical Model）：指人们在观察和处理健康与疾病问题的实践中形成的**总体认识框架和基本观点**。它反映了特定历史时期医学科学发展的整体水平、医学思维方式和对健康与疾病问题的基本认知方式，是人类与疾病作斗争、获取健康经验的总结。医学模式是**医学实践活动的指导思想**，影响和决定着医学教育、医学研究、临床诊疗和卫生服务的方向与模式。

[提示] 要点提示：医学模式的核心内容包括三个方面：

1. 疾病观——对疾病本质、原因和机制的基本认识
2. 健康观——对健康本质和标准的认识
3. 医学观——对医学目的、任务和方法的总体看法

2.2 医学模式的演变过程

2.2.1 神灵主义医学模式

[概念] 概念释义：神灵主义医学模式（Spiritualistic Medical Model）：原始社会中，人们将健康与疾病归因于**超自然力量**（神灵、鬼怪等），认为疾病是神灵惩罚或邪魔附体所致，健康是神灵赐福。对疾病的治疗主要依靠巫术、祈祷等驱鬼降神手段。

基本观点：

- 疾病 = 超自然力量的惩罚
- 治疗 = 巫术、祈祷、驱魔
- 医巫不分，健康与疾病被神秘化

2.2.2 自然哲学医学模式

[概念] 概念释义：自然哲学医学模式（Natural Philosophical Medical Model）：古代文明时期，人们开始用**自然哲学思想**来解释健康与疾病现象，将人体视为自然界的缩影，强调人与环境的和谐统一。

基本观点与代表：

1. **古希腊希波克拉底**——体液学说（四体液：血液、黏液、黄胆汁、黑胆汁），四种体液平衡即为健康。强调环境和生活方式对健康的影响，《空气、水与地域》阐述了环境与疾病的关系
2. **中国《黄帝内经》**——阴阳五行学说、天人合一思想。强调情志、饮食、起居、劳逸等对健康的影响，提出“上工治未病”的预防思想
3. **古印度**——三体液学说（气、胆、痰）

！重点掌握：自然哲学医学模式的核心特点：

- **整体观：**人体是一个整体，人与自然也是一个整体
- **平衡观：**健康是体内各要素的平衡，疾病是失衡
- 从自然哲学角度解释疾病，摆脱了纯粹的**Q**神灵迷信
- 开始重视环境、生活方式等因素对健康的影响

2.2.3 机械论医学模式

[概念] 概念释义：机械论医学模式（Mechanistic Medical Model）：文艺复兴后，随着物理学和机械力学的兴起，人们将人体视为一部**精密的机器**，疾病是机器零件损坏或功能失常，医生的任务是修理机器。

基本观点：

- 人体 = 精密的机器（心脏 = 泵、关节 = 杠杆、肺 = 风箱）
- 疾病 = 机器部件损坏
- 治疗 = 修复损坏的部件
- 代表：笛卡尔（“动物是机器”）、拉美特利（“人是机器”）

历史贡献与局限：

- 贡献：推动了实验医学和解剖学的发展，使医学摆脱了思辨哲学的束缚
- 局限：忽视了人体生命的复杂性和整体性；忽视了心理、社会因素的作用；将复杂的生命活动简化为机械运动

2.2.4 生物医学模式

[概念] 概念释义：生物医学模式（Biomedical Model）：以**生物学为基础**，从生物学角度认识和解释健康与疾病的医学模式。认为任何疾病都可以在器官、组织、细胞或分子水平上找到生物学的异常改变，每种疾病都可以找到特定的生物学病因和发病机制。

！重点掌握：生物医学模式的基本观点（理论基础）：

1. **病因学一元论**：每种疾病都有特定的生物或理化致病因子（病原体、毒素、理化因素等）
2. **器官定位论**：疾病定位于特定的器官、组织或细胞
3. **特异性治疗论**：针对特定病因采用特异性治疗方法
4. **还原论**：复杂的生命现象可以还原为物理、化学过程来解释
5. **心身二元论**：将躯体与精神分离，忽视心理因素的致病作用

[提示] 要点提示：生物医学模式的历史贡献：

1. 推动了现代医学的巨大进步——微生物学（科赫法则）、免疫学、麻醉、消毒技术、抗生素等的发现和应用
2. 在传染病和急性病的防治中取得了辉煌成就，显著降低死亡率和发病率
3. 建立了科学的疾病分类体系和诊断治疗方法
4. 促进了医学的专科化和精细化发展

生物医学模式的局限性：

1. 忽视了心理、社会因素在疾病发生发展中的作用
2. 将人简单还原为生物学个体，忽视了人的社会属性
3. 无法解释现代疾病谱的变化——慢性非传染性疾病、心身疾病等
4. 过度依赖技术和药物，导致医疗费用不断攀升
5. 忽视预防和健康促进的作用
6. 无法解释一些功能性疾病的病因

2.3 生物-心理-社会医学模式

2.3.1 产生的背景

！重点掌握：生物-心理-社会医学模式产生的四大背景：

1. **疾病谱和死因谱的转变**——从传染病为主转向慢性非传染性疾病（心脑血管病、恶性肿瘤、糖尿病等）为主。这些疾病的病因中，行为生活方式、环境、社会因素占重要地位
2. **对健康需求的提高**——人们不再满足于不生病，而是追求身体、心理和社会的完好状态
3. **医学科学的发展**——心理学、社会学、人类学等与医学的交叉融合，心身医学、行为医学的发展
4. **健康社会决定因素的认知**——大量研究证据表明社会因素对健康的影响至关重要

医学模式转变的流行病学证据：

5. 医学社会化

4. 医学学科内部融合与交叉发展

- 美国：前 10 位死因中，行为生活方式因素占 50% 以上，环境因素占 20%，生物学因素占 20%，卫生服务仅占 10%
- 中国：随着经济发展和老龄化，慢性病负担日益加重，危险因素以行为生活方式和社会环境因素为主

2.3.2 恩格斯的生物-心理-社会医学模式

[概念] 概念释义：Engel 的生物-心理-社会医学模式 (Bio-Psycho-Social Medical Model, 1977)：由美国罗切斯特大学精神病学和内科学教授 G.L. Engel 在《科学》杂志上发表论文正式提出。该模式认为，**健康与疾病是生物、心理和社会因素相互作用的结果**，要全面认识健康和疾病，必须考虑生物、心理和社会三个层面的因素及其相互作用。

！重点掌握：（教学难点 *）生物-心理-社会医学模式的基本内涵：

- ② - 强调了心理、社会因素在医学研究系统中的应有的位置
- ② - 更加准确肯定了生物因素的含义和生物医学的价值
- ② - 全方位探求影响人类健康与疾病的因果关系 健康问题是医学问题也是社会问题

八倍、五倍于行为生活方式因素、环境、生物、遗传、医疗卫生服务等单一因素的影响，单一因素仅占八分之一、五分之一因果。

3. **整体论：**人是一个完整的系统，不能还原为各个部分的简单叠加。医生需要将病人视为一个“完整的人”，而非仅仅是某种疾病的载体。
4. **患者中心论：**医疗服务应以患者为中心，关注患者的主观体验、心理状态和社会处境，而非仅关注疾病的客观指标。

[概念] 概念释义：环境健康医学模式 (Blum's Model, 1974)：由 Blum 提出，将影响健康的因素归纳为四大类：**环境因素、行为生活方式、生物遗传因素和医疗卫生服务**。其中**环境因素是最重要的健康决定因素**。

综合健康医学模式 (Lalonde-Dever 模型)：在 Blum 模型基础上的进一步发展，将影响健康的因素分为：人类生物学；环境；生活方式；卫生保健体系。

将影响人类健康及疾病的主要因素分为环境因素、行为生活方式、生物遗传、卫生服务等四大类，每一大类又包括三小类。

2.3.3 生物-心理-社会医学模式的意义

1. 对医学目的影响- 预防疾病和促进健康；- 解除疼痛和疾苦；- 治疗疾病和对不治之症的照料；- 预防早死和提倡安详地死亡。
2. 对卫生服务的影响：“四个扩大” (1)从治疗服务扩大到预防保健服务 (2)从生理服务扩大到心理服务 (3)从院内服务扩大到院外服务 (4)从技术服务扩大到社会服务
3. 对临床医学 整体思想，建立合作性的医患关系
4. 对预防工作 大卫生观
6. 医学教育 课程整合，加入人文课程学习

2.4 健康观的演变

2.4.1 消极健康观

[概念] 概念释义：消极健康观 (经典健康观)：将健康定义为“**没有疾病**” (Health is the absence of disease)。这种观点以疾病的生物学异常为参照，健康仅仅被理解为非疾病状态。

消极健康观的特点与局限：

- 以疾病为中心定义健康，标准明确但过于狭窄
- 忽视了健康的多维度性 (心理、社会维度)
- 无法涵盖亚健康状态和功能健康
- 与“生物医学模式”相适应

2.4.2 WHO 健康观

！重点掌握：世界卫生组织（WHO, 1948）的健康定义：

"Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity."

健康不仅是躯体没有疾病或虚弱，而且是身体、心理和社会适应的完好状态。

WHO 健康定义的深远意义：

1. 首次提出**三维健康观**——突破了“没有疾病 = 健康”的传统观念
2. 强调**社会维度**——社会适应良好是健康的重要组成部分
3. 将健康从“**消极**”定义转向“**积极**”定义
4. 蕴含**积极健康观**的理念——健康是积极追求的理想状态
5. 为新医学模式（生物-心理-社会医学模式）提供了理论基础
6. 推动医疗服务从“治病”转向“促进健康”

2.4.3 健康与疾病概念的扩展

[概念] 概念释义：疾病（Disease）、病患（Illness）与患病（Sickness）的区分：

- **Disease（疾病）**：医学上客观存在的病理生理学异常，可通过检查诊断确认，是**生物学层面的异常**
- **Illness（病患）**：患者主观感受到的不适、痛苦和功能受限等体验，是**心理学层面的感受**
- **Sickness（患病）**：社会对个体疾病状态的认可和反应，涉及社会角色、权利和义务，是**社会学层面的状态**

现代健康观的多维视角

1. **躯体健康**：身体结构完整、生理功能正常
2. **心理健康**：认知功能正常、情绪稳定、人格健全、良好的应对能力
3. **社会适应良好**：能有效扮演社会角色、维持良好的人际关系和社会功能
4. **道德健康**：行为符合社会道德规范，具有社会责任感和道德判断力
5. **亚健康状态**：介于健康与疾病之间的中间状态，表现为功能减退但无明显器质性病变

2.5 复习题

一、选择题

1. 生物-心理-社会医学模式的提出者是：
(A) Virchow
(B) Blum
(C) Engel
(D) Lalonde
2. 以下哪种医学模式将人体视为“机器”？
(A) 神灵主义医学模式
(B) 自然哲学医学模式
(C) 机械论医学模式
(D) 生物医学模式
3. WHO 健康定义的时间是：
(A) 1946 年
(B) 1948 年
(C) 1977 年
(D) 1978 年
4. 影响健康的环境因素中，Blum 模型认为最重要因素是：
(A) 生物遗传因素
(B) 行为生活方式
(C) 环境因素
(D) 医疗卫生服务

3.1 社会因素概述

包括一系列与社会生产力和生产关系有密切联系的因素，即以生产力发展水平为基础的经济状况、社会保障、环境、人口、教育以及科学技术，和以生产关系为基础的社会制度、法律体系、社会关系、卫生保健以及社会文明等。

[概念] 概念释义：社会因素（Social Factor）：指社会的各项构成要素，包括社会环境、社会经济、社会制度、社会文化、社会行为、卫生服务等，是影响人群健康的重要因素。

社会因素的内容：

- 社会经济因素——经济发展水平、收入、贫困等
- 社会环境因素——人口、营养、城市化、社会支持等
- 社会文化因素——教育、文化、宗教、风俗习惯等
- 行为心理因素——生活方式、心理压力、人格等
- 卫生服务因素——卫生资源配置、服务可及性等
- 社会制度因素——政治体制、社会保障制度等

3.2 健康社会决定因素的概念

健康社会决定因素被认为是决定人们健康和疾病的根本原因，包括了人们从出生、成长、生活、工作到衰老的全部社会环境特征，例如收入、教育、饮水和卫生设施、居住条件、社会区隔等，它也反映了人们在社会结构中的阶层、权力和财富的不同地位。

[概念] 概念释义：健康社会决定因素（Social Determinants of Health, SDH）：（教学难点*）指在那些直接导致疾病的因素之外，由人们的社会地位和所拥有资源所决定的生活和工作环境条件，及其对健康产生影响的社会性因素。即“影响健康影响因素的社会因素”——决定人们健康水平的“原因的原因”（causes of the causes）。

！重点掌握：理解“原因的原因”：

- 直接病因：如吸烟 → 肺癌（直接因果关系）
- SDH：如低教育水平 → 吸烟率高 → 肺癌（社会因素是直接病因背后的深层原因）
- SDH 关注的是健康不公平的社会根源——为什么有些人比其他更容易生病？
- 核心观点：社会不平等 → 健康不平等，社会结构性因素决定了人群健康状况的系统性差异

3.3 健康社会决定因素理论的发展

表 3.1: 健康社会决定因素理论发展历程

时间	主要事件与发展
19 世纪	Virchow、Engels 等关注社会条件与疾病关系，认为疾病根源在于社会不平等
1948 年	WHO 成立，宪章确立健康权为基本人权，承认社会条件对健康的重要性
1978 年	Alma-Ata 宣言，提出“人人享有卫生保健”目标，强调初级卫生保健和社会公平
1980 年代	英国 Black Report（黑报告）揭示社会阶层间健康状况的梯度差异
1990 年代	加拿大、荷兰等国开始系统研究健康的社会决定因素
2003 年	WHO 出版《健康社会决定因素：确凿事实》
2005 年	WHO 成立健康社会决定因素委员会（CSDH）
2008 年	CSDH 发布《用一代人时间弥合差距》最终报告，提出三大行动原则
2009 年	第 62 届世界卫生大会通过决议，推动各国行动
2011 年	《里约政治宣言》进一步确认 SDH 的重要性，提出五大行动领域

健康社会决定因素理论对社会医学的理论发展的意义

1. 强化了从社会因素分析健康与疾病关系的理论基础。
2. 从社会因素角度研究健康不公平
3. 探索新的研究方法

！重点掌握：CSDH（2008）三大行动原则：

1. **改善日常生活条件**——从出生开始改善儿童早期发育；改善居住环境和工作条件；建立全民社会保障制度
2. **改变权力、资金和资源分配的不公平**——将健康公平纳入政府各部门政策；建立公平的筹资机制；增强市场行为的规范性
3. **测量和理解问题并评估行动效果**——建立健全的健康公平监测体系；培训研究人员；扩大公众对 SDH 的认知

3.4 健康社会决定因素的理论模型

3.4.1 Dahlgren 和 Whitehead 模型（1991）

！重点掌握：Dahlgren 和 Whitehead 于 1991 年提出的**彩虹模型**是最经典的健康社会决定因素理论模型，将影响健康的因素分为五个层次：

1. **核心层——个体因素：**年龄、性别、遗传因素（不可改变的个人特征）
 2. **第二层——个人生活方式：**吸烟、饮酒、饮食、体力活动等健康相关行为
 3. **第三层——社会与社区网络：**家庭支持、朋友网络、社区参与等社会关系因素
 4. **第四层——生活与工作条件：**住房、工作环境、教育、医疗服务、水和卫生设施、农业和食物生产、失业等
 5. **最外层——宏观社会经济、文化和环境条件：**国家经济政策、社会文化价值观、政治制度、全球化等
- 该模型强调：**从内到外的影响路径**——外层因素通过影响内层因素最终影响个体健康；**从外到内的决定路径**——越外层的因素影响力越广泛深远。

3.4.2 WHO 的 SDH 行动框架

[概念] 概念释义：WHO 健康社会决定因素委员会（CSDH）行动框架将影响健康的社会因素分为两大类：

1. **结构性决定因素（Structural Determinants）：**社会经济和政治环境（社会治理、经济政策、社会政策、公共政策、文化和社会价值观）与社会经济地位（收入、教育、职业、社会阶层、性别、种族/民族）
2. **中介决定因素（Intermediary Determinants）：**物质环境（住房、居住环境、工作环境等）、社会心理环境（社会支持、压力等）、行为和生物因素、卫生系统

3.5 影响健康的主要社会因素

3.5.1 社会因素影响健康的规律与特点

！重点掌握：社会因素影响健康的五大特点：

1. **非特异性：**社会因素对健康的影响往往是广泛而非特异性的。同一社会因素可影响多种健康结局（如贫困可增加多种疾病的发病率和死亡率）
2. **交互作用：**各种社会因素之间相互影响、相互制约，共同作用于人群健康。社会经济、文化、行为因素之间存在复杂的交互效应
3. **累积效应：**社会因素对健康的影响往往具有长期累积效应。如生命历程中不同阶段的社会经济劣势可累积为成年后的健康损害
4. **广泛性和持久性：**社会因素影响整个人群，其作用持久而深远，往往跨越一代人
5. **双向性：**社会因素与健康之间存在双向关系——不良社会条件损害健康，而健康损害又会加剧社会劣势，形成恶性循环

泛影响性
恒常

3.5.2 主要社会因素

影响健康的主要社会因素

1. **社会经济因素**：收入水平、贫富差距、经济发展阶段
2. **社会制度因素**：政治体制、法律制度、社会保障制度
3. **社会文化因素**：教育水平、文化传统、价值观念、
4. **社会人口因素**：人口数量、结构、素质、流动与迁
5. **社会关系因素**：家庭关系、社会支持网络、社区参
6. **社会行为因素**：健康相关行为、生活方式、吸烟、
7. **卫生服务因素**：卫生资源的配置、质量、可及性和
8. **环境因素**：自然环境（空气、水、土壤）、建成环境

影响健康的主要社会因素

- 年龄、性别和遗传因素 歧视问题
- 个体生活方式
- 社会支持网络
- 社会经济地位
- 其它社会结构因素(工作环境、城市化、 卫生保健服务等)
- 宏观社会经济、文化和环境 政治

3.6 将健康融入所有政策

[概念] 概念释义：将健康融入所有政策（Health in All Policies, HiAP）：由 WHO 倡导，指在制定所有公共政策和决策时，系统性地、明确地考虑其对人群健康的影响，明确跨部门责任，加强部门协作，以实现改善人群健康和健康公平的目标。

避免健康不良影响

！重点掌握：HiAP 的核心理念：

1. 健康不仅是卫生部门的职责，政府部门的所有决策都可能影响健康
2. 需要跨部门合作和政府高层领导的承诺
3. 政策制定应考虑对健康的长远影响和在不同人群中的分布
4. 实现健康公平是社会正义的体现

HiAP 的实践领域（WHO, 2014 年提出 6 个关键组成部分）：

1. 确定 HiAP 的需求和优先领域
2. 建立必要的组织框架和行动计划
3. 建立支持性的机制和流程
4. 增强跨部门协作的能力
5. 确保监测、评估和报告
6. 加强培训 and 能力建设

❓ 基础:健康相关的权利和义务

❓ 关注:公共政策对健康决定因素的后续影响

❓ 目的:提高各级政策制定者对于健康的 责任

[提示] 要点提示：中国 HiAP 实践：

- 2013 年国家卫生计生委发布《“健康中国”战略规划》
- 2016 年《“健康中国 2030”规划纲要》将“将健康融入所有政策”确立为核心理念
- 爱国卫生运动是 HiAP 在中国的早期实践——多部门参与、全社会动员
- 健康影响评价制度正在逐步建立和完善

3.7 复习题

一、选择题

1. 健康社会决定因素（SDH）的核心观点是：
(A) 遗传因素是健康的最主要决定因素
(B) 社会结构性因素是健康不公平的根源
(C) 个人行为是健康的唯一决定因素
(D) 医疗技术水平决定人群健康水平
2. Dahlgren 和 Whitehead 的彩虹模型中，最外层影响因素是：
(A) 个人生活方式
(B) 社会与社区网络
(C) 生活与工作条件
(D) 宏观社会经济、文化和环境条件
3. WHO 成立 CSDH（健康社会决定因素委员会）的时间是：

❓ 经济是指一个国家国民经济的总称。包括 一国全部物质资料生产部门及其活动和部 分非物质资料生产部门及其活动。

❓ 经济发展(economic development)是人类 不断改善生产生活质量、逐步摆脱贫困落 后状态、持续提高社会经济福利 的过程， 其终极目标落脚于人们幸福生活的最终实 现。

4.1 经济发展水平的衡量指标

4.1.1 宏观经济指标

[概念] 概念释义：国内生产总值（Gross Domestic Product, GDP）：在一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值总和。是衡量国家经济状况的最常用指标。

国民生产总值（Gross National Product, GNP）：一个国家（或地区）所有国民在一定时期内生产的最终产品和劳务的价值总和。GNP = GDP + 来自国外的净要素收入。

4.1.2 综合发展指标

主要综合发展指标

- 1. 人类发展指数（Human Development Index, HDI）：联合国开发计划署（UNDP）1990 年提出，综合反映国家社会经济发展水平。包括三个维度：
 - 健康长寿——以出生时预期寿命衡量
 - 教育获得——以成人识字率和综合入学率衡量
 - 生活水平——以人均 GDP（购买力平价 PPP）衡量HDI 值 0-1，≥0.800 为极高人类发展水平，0.700-0.799 为高，0.550-0.699 为中等，<0.550 为低
- 2. 物质生活质量指数（Physical Quality of Life Index, PQLI）：由婴儿死亡率、1 岁期望寿命和识字率三项指标综合而成，用于衡量穷国贫民生活状况
- 3. 真实进步指标（Genuine Progress Indicator, GPI）：在 GDP 基础上调整环境成本和社会代价，更真实地反映经济福利水平
- 4. 国民幸福指数（National Happiness Index, NHI）：综合测量国民对生活满意程度的主观感受
- 5. 全球幸福指数（Global Happiness Index, GHI）：联合国发布的各国居民幸福程度排名指数

4.2 健康的衡量指标

表 4.1: 常用健康衡量指标

指标类型	具体指标
人口统计指标	出生率、死亡率、婴儿死亡率（IMR）、孕产妇死亡率（MMR）、期望寿命
疾病统计指标	发病率（Incidence Rate）、患病率（Prevalence Rate）
综合健康指标	健康期望寿命（HALE）、伤残调整寿命年（DALYs）、质量调整寿命年（QALYs）
卫生服务指标	卫生总费用（THE）及其占 GDP 比重、人均卫生费用

！重点掌握：婴儿死亡率（IMR）是反映一个国家或地区社会经济和卫生发展水平的最敏感指标之一，也是衡量人群健康状况的核心指标。

期望寿命（Life Expectancy）是评价人群健康状况和社会发展水平的综合性指标。

卫生总费用（Total Health Expenditure, THE）：一个国家或地区在一定时期内全社会用于卫生保健支出的货币总和，包括政府卫生支出、社会卫生支出和居民个人现金卫生支出。

4.3 经济发展水平与健康的双向作用

4.3.1 经济发展对健康的促进作用

！重点掌握：（教学难点*）经济发展促进健康的途径：

1. **改善物质生活条件**——提高人们的收入水平，改善营养、住房、衣着等基本生活条件
2. **增加卫生投入**——经济发展 → 政府财政收入增加 → 公共财政中卫生支出增加 → 卫生基础设施改善
3. **提高教育水平**——教育水平的普遍提高增强人们的健康意识和卫生知识，促进健康行为的形成
4. **完善社会保障**——建立和完善医疗保险、养老、工伤、失业等社会保障制度
5. **改善环境卫生**——安全饮水、卫生厕所、垃圾处理等环境卫生条件的改善

经济发展与健康关系的一般规律：经济发展水平越高的国家，期望寿命越长，婴儿死亡率越低，传染病发病率越低。但同时，慢性非传染性疾病、精神疾患和伤害的比例随经济发展而升高。

4.3.2 经济发展对健康的负面效应

经济增长与健康水平之间并不存在必然联系。当经济发展到一定水平，影响健康的不再是经济的绝对水平，而是社会经济的公平性。

！重点掌握：经济发展对健康的不利影响：

1. **环境污染与生态破坏**——工业化带来空气、水、土壤污染；气候变化和生物多样性减少对健康构成长期威胁
2. **不良行为生活方式的增加**——高热量饮食、体力活动减少、吸烟、酗酒等与经济发展伴随的不良生活方式
3. **心理健康问题的增加**——竞争加剧、生活节奏加快、社会关系疏离导致心理压力增大，抑郁症和焦虑症等精神疾病增加
4. **职业健康危害**——工伤、职业病、职业压力等与生产活动相关的健康问题
5. **社会不平等加剧**——贫富差距扩大直接导致健康不公平；相对剥夺感对低收入群体心理健康的损害
6. **交通事故和伤害增加**——机动车数量增加导致交通事故伤害增多
7. **传染病流行风险**——经济全球化增加新发传染病跨国传播的风险（如 COVID-19 大流行）
8. **食品安全问题**——食品工业化生产带来食品安全隐患

4.3.3 健康对经济发展的促进作用

！重点掌握：健康促进经济发展的路径：

1. **提高劳动生产率**——健康的劳动力具有更高的工作效率和更低的缺勤率
2. **增加教育投资回报**——健康的儿童学习能力更强，教育投资回报率更高
3. **增加劳动力供给**——更长的健康寿命延长了劳动力参与时间
4. **减少疾病经济负担**——预防疾病减少直接医疗费用支出和间接生产力损失
5. **促进储蓄和投资**——健康人群更有可能进行长期储蓄和生产性投资
6. **释放“人口红利”**——健康水平提高是人口红利转化为经济增长红利的前提条件

表 4.2: 经济发展与健康关系的国际比较

国家类型	人均 GNI (美元)	IMR (‰)	MMR (万/10万)	期望寿命 (岁)	THE 占 GDP (%)
低收入国家	约 600-3000	30-90	200-500	60-68	4-6
中等收入国家	约 3000-12000	10-30	50-200	68-76	5-8
高收入国家	>12000	3-10	<50	78-84	8-12

4.3.4 经济发展与健康的双向作用总结

！重点掌握：经济发展与健康的关系并非简单的线性关系：

1. 总体上呈**正相关**——经济发展水平越高，人群健康水平越高
2. 关系呈**边际递减效应**——经济发展在较低水平时对健康的促进作用最显著，达到一定水平后促进作用减弱
3. 存在“**双刃剑**”效应——经济发展既带来健康红利，也带来新的健康风险
4. 需要**政策引导**——通过社会政策调节经济发展对健康的影响，将健康红利最大化，健康风险最小化

4.4 健康投资

[概念] 概念释义：健康投资（Health Investment）：为保护和增进人群健康而投入的各种资源，包括人、财、物、时间、信息等。健康投资不仅包括对医疗卫生服务的直接投入，还包括为提高健康水平而进行的社会性投入（教育、环境保护、住房改善等）。

4.4.1 健康投资的内涵

1. **卫生服务投资：**对医疗卫生机构、设备、人员、技术等投入
2. **公共卫生投资：**疾病预防控制、健康教育、环境卫生等投入
3. **社会性健康投资：**教育、营养改善、住房改善、安全饮水、社会保障等间接促进健康的投入
4. **个人健康投资：**个人为维护健康所投入的时间、金钱和精力

4.4.2 健康投资效益分析

[概念] 概念释义：健康投资的效益可从微观（个人/家庭）和宏观（社会/国家）两个层面理解：

- **微观效益：**减少个人医疗支出、减少因病收入损失、提高个人劳动生产力、提高终身收入
- **宏观效益：**减少社会疾病经济负担、提高人力资本质量和数量、促进经济持续增长、减少贫困、促进社会公平

！重点掌握：健康投资的经济学意义：

1. 健康是**人力资本**的重要组成部分，健康投资是人力资本投资的核心内容
2. 健康投资具有**高回报率**——据 WHO 估算，每投入 1 美元用于健康改善，可获得 2-4 美元的回报
3. 健康投资是**经济可持续发展的基础**，“健康中国 2030”战略明确了健康在经济社会发展中的优先地位
4. 预防性健康投资（公共卫生、健康教育等）的**成本效益比最高**
5. 卫生总费用（THE）占 GDP 的比重是衡量一个国家或地区健康投资水平的重要指标

4.5 复习题

一、选择题

目的：维持或提高现有健康存量（耐久资本）

健康存量增加：吸收营养，接受卫生服务，运动锻炼，教育等（健康投资）

健康存量减少：疾病、营养不良、衰老、劳损等（折旧）

影响因素：经济收入，贫困线收入，性别，教育水平，体能特征，种族特征，年龄，医疗保险等

意义：

- ☐ 减轻潜在疾病的经济负担
- ☐ 改善人群的健康水平
- ☐ 促进经济发展、社会进步和国家安全

☐ 投资主体

— 私人健康人力资本投资

家庭营养保健支出、医疗的私人支出部分、居住环境改善、休息等

增加正面投资和减少负面投资

— 公共健康人力资本投资

医疗卫生设施建设，公共卫生环境建设，医疗工作者的薪酬支付以及居民医疗补贴等

二、名词解释

1. 健康投资（Health Investment）

人口增长过快和人口数量过多对人类健康的影响:

- ❑ 加重社会负担, 影响人群生活质量
- ❑ 加重教育及卫生事业的负担, 影响人口素质
- ❑ 加重环境污染和破坏

人口增长过慢(负增长)对人类健康的影响:

- ❑ 经济发展减缓
- ❑ 加重社会老年人口抚养负担, 影响人群 生活质量

5.1 人口与健康

5.1.1 人口数量与健康

[概念] 概念释义: 人口数量与健康的关系:

- 人口过多 → 资源(粮食、水、能源)紧张 → 营养不良、环境污染、居住拥挤 → 传染病易于传播
- 人口过少 → 劳动力不足 → 经济发展受限 → 卫生投入不足
- 人口密度过高增加传染病传播风险和心理压力
- 世界人口持续增长对全球卫生系统构成持续性压力

5.1.2 人口结构与健康 (教学难点 *)

主要包括性别、年龄、收入、人种、民族、宗教、教育程度、职业、家庭人数等。

! 重点掌握: (教学难点 *) 人口年龄结构与健康:

1. 年龄结构类型:
 - 年轻型(增长型)——0-14 岁人口占比 ≥40%, 65 岁及以上 ≤4%
 - 成年型(稳定型)——0-14 岁占 30-40%, 65 岁及以上占 4-7%
 - 老年型(缩减型)——0-14 岁 ≤30%, 65 岁及以上 ≥7%
2. 人口老龄化: 60 岁以上人口占总人口比例 ≥10% 或 65 岁以上 ≥7% 即为老龄化社会
3. 老龄化的健康影响:
 - 慢性非传染性疾病负担加重(心脑血管病、肿瘤、糖尿病等)
 - 老年综合征(跌倒、失能、痴呆、抑郁等)增加
 - 长期照护需求急剧增长
 - 社会保障和医疗卫生系统压力增大
4. 抚养系数:
 - 总抚养系数 = [(14 岁及以下人口数 + 65 岁及以上人口数) / 15-64 岁人口数] × 100%
 - 少儿抚养系数 = (14 岁及以下人口数 / 15-64 岁人口数) × 100%
 - 老年抚养系数 = (65 岁及以上人口数 / 15-64 岁人口数) × 100%
5. 性别结构: 出生性别比 = (某年活产男婴数 / 同年活产女婴数) × 100, 正常范围为 103-107。性别比失调会带来一系列社会健康和稳定问题 • 影响人口再生产 • 影响社会稳定 • 影响农村社会经济发展

人口金字塔的三种类型:

- 增长型(年轻型)——塔底部宽、顶部尖, 年轻人比重大, 预示着人口将持续快速增长
- 稳定型(成年型)——塔底和塔身宽度基本接近, 塔尖逐渐收缩, 各年龄段人口比例相对均衡
- 缩减型(老年型)——塔底窄、塔身宽, 年轻人口少、中老年人口比例大, 预示着人口将逐渐减少

用条形图来表示人口的性别年龄结构。通过人口金字塔, 可以看出各年龄组的男性和女性数及其构成, 并可分析出过去几十年人口出生与死亡和将来几十年的人口发展。

5.1.3 人口素质与健康

[概念] 概念释义: 人口素质包括三个方面:

1. 思想道德素质 是衡量人口素质的重要标志, 是人们在处理社会关系时的指导思想和道德规范。
2. 科学文化素质——受教育水平直接影响健康知识获取和健康行为养成
3. 身体素质——包括体格发育、生理机能、智力水平等, 与遗传、营养、环境有关

出生缺陷是影响人口素质的重要因素——我国出生缺陷发生率约为 5.6%, 是婴儿死亡和儿童残疾的首要原因, 带来沉重的社会疾病负担。

PQLI ASHA

5.1.4 人口流动与健康（教学难点*）人口在地理空间位置上的变动和阶层职业上的变动。

！重点掌握：（教学难点*）人口流动对健康的影响：
流动人口面临的主要健康问题：

- ❑ 人口流动是一个社会或地区经济发展的必然产物，一种普遍存在的社会现象。
- ❑ 人口流动可促进经济繁荣和社会发展。
- ❑ 但如果人口流动量过多或过速，也会产生负面作用，如增大城市人口拥挤，从外地带入某种疾病，或引起传染病爆发流行。
- ❑ 流动人口的家庭化也给卫生服务带来了困难和压力。
- ❑ 高危人群：儿童，老年人和孕产妇

5.2 营养、食品安全与健康

5.2.1 营养与健康

1. **营养不良**——包括营养不足（消瘦、发育迟缓、微量营养素缺乏）和营养过剩（超重、肥胖）。我国面临营养不良的**双重负担**
2. **营养过剩**——导致肥胖、2型糖尿病、心血管疾病、某些癌症的风险增加
3. **膳食结构不合理**——高盐、高脂、低蔬菜水果摄入增加慢性病风险

5.2.2 食品安全

[概念] 概念释义：食品安全（Food Safety）：指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。

！重点掌握：食品安全事件的危害：

1. 急性食源性疾病——微生物污染（细菌、病毒）导致食物中毒
2. 慢性健康损害——农药残留、重金属、食品添加剂等长期低剂量暴露
3. 社会恐慌和社会心理影响
4. 经济损失——影响食品产业和国际贸易

食品安全的社会防治：

1. 完善食品安全法律法规和标准体系（《食品安全法》）
2. 建立食品安全全程监管体系——从农田到餐桌
3. 加强食品安全风险监测与评估
4. 提高食品安全检测技术和能力
5. 加强食品安全教育和信息沟通
6. 鼓励社会监督和参与

体力活动(Physical activity)/身体活动：指通过人体肌肉骨骼活动而产生能量消耗的各种活动。

* 根据骨骼肌收缩时能量供应途径，分为：-有氧运动-无氧运动

* 根据人们的日常生活安排，每人每天的日常体力活动可分为：-职业性体力活动 -交通行程性体力活动 -家务性体力活动 -闲暇时间体力活动(运动锻炼)

* 按生理功能分类 -有氧运动 -抗阻力活动 -关节柔韧性活动 -身体平衡和协调性练习

5.3 体力活动、职业压力与健康

5.3.1 体力活动与健康

1. **缺乏体力活动**已成为全球第四大死亡危险因素
2. 适量体力活动可降低心血管疾病、糖尿病、某些癌症、抑郁症的风险
3. WHO 建议成人每周至少 150 分钟中等强度有氧运动
4. 久坐生活方式（Sedentary Lifestyle）是独立的健康危险因素

静态行为(Sedentary behavior)是指人一天坐着较长时间的行为，包括工作、学习和休闲所坐的时间。

5.3.2 职业压力与健康

清醒时坐或倚靠着代谢当量(metabolic equivalents, METs) $\leq 1.5 \text{ kcal/kg}\cdot\text{h}$ (即 $\leq 6.276 \text{ kJ/kg}\cdot\text{h}$) 的行为。

[概念] 概念释义：职业压力（Occupational Stress）：当工作要求与工作者的能力、资源或需求不匹配时产生的有害的生理和情绪反应。

职业压力的健康影响：心血管疾病、心理障碍（抑郁、焦虑、职业倦怠）、免疫功能下降、肌肉骨骼疾患增加。

5.4 城市化与健康

城市数量增加 或城市规模扩大的过程，其结果表现为城市 人口在社会总人口中的比例逐渐上升。

[概念] 概念释义：城市化 (Urbanization)：由农业为主的传统乡村社会向以工业和服务业为主的现代城市社会逐渐转变的历史过程。

！重点掌握：城市化对健康的影响：

积极影响：

1. 卫生服务可及性更好
2. 教育机会更多 → 健康素养更高
3. 就业机会和收入水平较高
4. 基础设施（供水、排污、交通）改善

消极影响（“城市病”）：

1. 环境污染（空气、噪声、光污染）
2. 生活节奏快、竞争压力大 → 心理问题
3. 慢性病高发（饮食西方化、久坐生活方式）
4. 交通拥堵和交通事故
5. 社会关系疏离 → 社会支持减弱
6. 传染病在密集人口中的传播风险
7. “城市贫民窟”问题——居住条件恶劣、卫生设施缺乏

人口膨胀：城市建设和管 理跟不上迅速增长的需求， 导致各 类城市基础设施的 供给滞后于城市人口的增 长，引发一系列 的矛 盾，出现环境污染、就业 困难、治安恶化等城市病

城乡差距↑
移民健康问题↑
卫生资源拥挤效应

5.5 社会网络与社会支持

5.5.1 社会网络

[概念] 概念释义：社会网络 (Social Network)：个人与其他人之间所有社会联系所构成的网络系统。社会网络以个体为中心，围绕个体的社会关系形成。

- **社会网络的功能：**提供社会支持；传递信息和价值观；影响健康行为；提供社会参与机会
- 社会网络的密度、规模、强度和互惠性影响其对健康的保护作用

5.5.2 人际关系与社会支持

人类社会中人 与人相互联系 和相互作用过程中形成的一种复杂的关系。和谐、融洽的人际关系是人们获得社会支 持的情感条件，也是获得社会支持的基础。

[概念] 概念释义：人际关系 (Interpersonal Relationship)：人们在社会交往过程中形成的各种关系的总称，包括家庭关系、朋友关系、同事关系、邻里关系等。

！重点掌握：社会支持 (Social Support)：个人从社会网络中所获得的物质和精神的帮助与支持。

一客观的支持。指可见的或实际的，包括物质上的直接援助、团体关系的存在和参与等。（物质支持和生活支持）
一主观的支持。指个体体验到的或情感上感受到 的支持。是指个体在社会中受尊重、被支持与理 解的情感体验和满意程度，与个体的主观感受密 切相关。

社会支持对健康的影响机制：提供维护和促进健康所需要的物质资源

1. **直接效应（主效应模型）：**良好的社会支持直接促进健康，无论是否处于应激状态
2. **缓冲效应（压力缓冲模型）：**社会支持缓冲压力事件对健康的负面冲击
3. 社会支持可改善免疫功能、降低心血管反应性、促进健康行为

5.6 家庭与健康

5.6.1 家庭的类型与功能

[概念] 概念释义：家庭是以婚姻和血缘关系为基础建立起来的社会生活的基本单位。

家庭类型：

- 核心家庭——由父母和未婚子女组成
- 扩展家庭——由两代或两代以上的夫妇及子女组成
- 单亲家庭
- 其他特殊家庭（重组家庭、空巢家庭等）

家庭功能：

1. 生育功能

1. 生殖功能 2. 社会化功能 3. 情感功能

4. 健康照顾功能 工具性和情感性 5. 经济功能

5. 社会化功能——价值观、行为规范的内化

6. 健康照顾功能——为家庭成员提供工具性和情感性健康支持

家庭功能评估——Family APGAR 问卷：

- A（Adaptation，适应度）——家庭遭遇危机时，利用内外资源解决问题的能力
- P（Partnership，合作度）——家庭成员分担责任和共同作出决定的程度
- G（Growth，成长度）——家庭成员通过互相支持所达到的身心成熟和自我实现程度
- A（Affection，情感度）——家庭成员间相互关爱、表达情感的程度
- R（Resolve，亲密度）——家庭成员共享时间、空间和金钱的程度

核心家庭：结构简单，一个权力和活动中心，容易沟通 相处

主干家庭：一个主要的权力和活动中心，一个权力和活动的次中心。

联合家庭：同一代至少有两对及两对以上夫妇的家庭。特点：结构复杂，家庭内存在一个主要的权力和活动中心，数个权力和活动的次中心。

其它家庭(非传统类型家庭)：以上三类以外的，如单身家庭、单亲家庭、同居家庭、同性恋家庭、隔代家庭等。

5.6.2 家庭对健康的影响

！重点掌握：家庭对健康的积极影响：

1. 提供情感支持——减少心理问题和精神疾病
2. 影响健康行为的形成——饮食、运动、卫生习惯等
3. 在疾病时提供照护
4. 提供经济和物质保障

家庭对健康的消极影响：

1. 家庭暴力——直接躯体伤害和心理创伤
2. 家庭功能失调——增加成员患病风险
3. 家庭压力（离婚、丧偶、经济困难等）——增加心理和躯体疾病风险
4. 家庭中传染病传播（如结核病、肝炎等）

• 遗传和先天的影响

• 家庭对儿童生长发育及社会化的影响

• 家庭环境对健康的影响

• 家庭对生活习惯和行为方式的影响

• 家庭对成年人发病率和死亡率的影响

5.7 退休、失业与健康

1. **失业与健康：**失业导致收入下降、社会地位丧失、心理压力增加，与死亡率升高、心理健康问题、自杀风险增加密切相关
2. **退休与健康：**退休是人生重要的角色转换，适应良好者健康不受影响甚至改善，适应不良者可能出现“退休综合征”——抑郁、失落感、躯体不适等

5.8 社会阶层与健康

[概念] 概念释义：社会阶层（Social Class/Social Stratum）：由于经济、政治、社会等多种原因形成的，在社会层次结构中处于不同地位的社会群体。划分社会阶层的三大指标：**经济地位/收入**（最主要）、**职业、教育水平**。

中国的十大社会阶层（中国社会科学院划分）：

1. 国家与社会管理者阶层
2. 经理人员阶层
3. 私营企业主阶层
4. 专业技术人员阶层

5. 办事人员阶层
6. 个体工商户阶层
7. 商业服务业员工阶层
8. 产业工人阶层
9. 农业劳动者阶层
10. 城乡无业、失业、半失业者阶层

！**重点掌握：**社会阶层对健康的影响（健康梯度现象）：

1. **健康梯度（Health Gradient）**：社会阶层每上升一个层级，健康状况和期望寿命均有改善，形成从高到低的梯度关系，而非仅“两极”差异
2. 低社会阶层人群具有更高的死亡率、发病率和更低的期望寿命
3. **影响机制：**
 - 物质路径：收入差异 → 生活条件、营养、医疗可及性差异
 - 心理路径：低社会地位 → 相对剥夺感、失控感 → 慢性应激
 - 行为路径：健康素养差异 → 健康行为差异
 - 生命周期累积：生命历程中社会劣势的累积效应
4. **Wilkinson 假说**：在富裕国家，社会不平等程度（而非平均收入水平）是决定人群健康水平的关键因素

5.9 复习题

社会阶层较低的人群：

- 遭受更多不良刺激
- 缺乏足够的社会支持
- 教育水平低，影响处理应激能力
- 较多的不良卫生习惯
- 较少的卫生保健机会

社会阶层较高的人群：

- 承受较高的职业压力
- 情绪障碍性疾病的发生率可能较高

3. 以下属于“健康梯度”现象的是：

- (A) 只有最贫困和最富有人群的健康存在差异
- (B) 社会阶层每上升一级，健康状况均有改善
- (C) 社会阶层与健康完全无关
- (D) 中产阶级的健康状况最差

4. 正常出生性别比的范围是：

- (A) 95-100
- (B) 103-107
- (C) 110-115
- (D) 100-103

二、名词解释

1. 社会支持（Social Support）
2. 健康梯度（Health Gradient）
3. 城市化（Urbanization）
4. 人口老龄化

三、简答题

1. 试述人口流动对健康的影响。
2. 简述社会支持的类型及其对健康的影响机制。

6.1 文化概述

狭义的文化是指精神文化，指人类的一切精神财富的总和，包括思想意识、观念形态、文学艺术、社会道德规范、法律、宗教信仰、风俗习惯、教育、科学技术、知识等。

[概念] 概念释义：文化 (Culture)： 广义指人类在社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和；狭义指社会的意识形态以及与之相适应的制度和组织机构。社会医学主要关注**狭义文化**——包括思想观念、价值体系、道德规范、语言文字、科学技术、宗教、艺术等精神文化要素。

文化的构成

- 1.文化的认知成分(知识、信仰)：知识是人们对自然和社会的客观认识。信仰是人们对自然和社会的主观认识。
- 2.文化的规范成分(价值观、社会规范)，文化的最深层次是价值观，价值观是文化的核心。价值观是人们对现实生活中各种事物和各类现象的认知评价，通常以正确与错误、道德与失德、应该与不应该等形成决定取舍的基本观点和所持态度。社会规范则是指导人们日常行为的约定俗成的、不成文规则和通过规章、制度、法律等形成的明文规定。
- 3.文化的符号成分：符号是任何能有意义表达的东西，它不依赖于符号本身的品质，能够为同一社会文化背景中的人所认同。最重要的文化符号成分:语言、文字

6.1.2 文化的特征与类型

！重点掌握：文化的特征：

1. **历史继承性**——文化是历史传承的产物，通过社会化过程代代相传
2. **社会共享性**——文化是社会群体共享的知识和信念体系
3. **适应性**——文化随社会环境变化而演变和调整
4. **民族性和区域性**——不同民族和地区具有不同的文化特性
5. **习得性**——文化不是遗传的，而是后天学习和获得的

文化的类型：

智能文化:人们改造客观世界能力的经验总结，如生产知识、科学技术；
规范文化:人类明文规定的系列行为准则，如政治法律、伦理道德、风俗习惯、教育；
思想文化:人类思维活动对客观存在反映的精神产品，如思想意识、观念形态、宗教信仰、文学艺术等。

6.2 文化对人群健康的影响

6.2.1 文化影响健康的作用模式（教学难点*）

！重点掌握：（教学难点*）文化影响健康的四大作用模式：

1. **文化决定健康观念模式：**不同文化下的疾病认知、病因解释和健康信念显著不同，影响人们求医行为和健行选择。例如：不同文化对“健康”和“疾病”的定义存在差异；不同文化对疼痛、不适的表达方式不同
2. **文化塑造健康行为模式：**饮食文化（西方高脂饮食 vs. 地中海饮食 vs. 东方饮食）、饮酒文化、吸烟文化等直接影响健康。文化价值观和规范通过社会化过程内化为个人的日常行为习惯
3. **文化影响卫生服务利用模式：**传统文化和民间医学影响人们对现代医疗和传统医疗的选择偏好。不同文化群体对精神卫生服务的利用存在显著差异（病耻感、对病因的文化解释等）

4. **文化调节心理应激反应模式**：文化决定应激源的评价方式（什么是“压力”）、应对策略的选择（求助、回避、情绪调节等）和社会支持的可获得性。集体主义文化与个人主义文化在应对方式上存在显著差异

6.2.2 文化影响健康的特点

1、无形性 潜移默化 2、本源性 文化根源 3、软约束性 自发行动 4、稳定性 代际传递 5、民族性 差异性

1. **潜移默化性**——文化对健康的影响往往是不自觉的、渐进的、内在化的
2. **广泛渗透性**——文化影响渗透到日常生活的方方面面，涉及饮食、起居、求医等各个环节
3. **持久稳定性**——文化价值观念和传统习俗根深蒂固，难以短时间改变
4. **双重性**——文化对健康既可能有积极促进作用，也可能有消极损害作用
5. **群体差异性**——不同文化背景人群的健康状况和健康行为存在显著差异

6.3 教育对健康的影响

文化对人们健康和疾病的认知和判断、人们的心理健康、躯体健康、卫生服务的利用和提供等等各方面都会产生广泛的、深刻的影响。

1. **教育与人的社会化**：社会化是指人从一个自然人转化为一个能够适应一定的社会环境、履行一定角色职能的社会人的进程。教育是人的社会化的过程和手段。
2. **教育与生活方式**：生活方式是人们采取的生活模式或式样，以经济为基础，以文化为导向。文化对人们生活方式的导向作用表现在多个方面，思想观念、宗教、科学技术、道德伦理、风俗习惯、文化艺术、教育均可以从不同侧面影响人的生活方式。教育通过培养人的文化素质来指导人的生活方式。
3. **教育与卫生服务利用**：受教育程度较高者对卫生知识教育和宣传表现出有渴求欲望，保护健康的意识浓烈，更主动积极寻求卫生服务。
4. **教育与就业机会及收入**：个体受教育程度越高，工作能力越强，获得就业机会和劳动收入越多，利用社会资源的能力越强，获得健康信息和服务的机会越多

6.4 科技进步对行为与健康的影响

1. **积极影响**：医学技术进步（诊断、治疗、预防手段革新）、健康信息技术（电子健康档案、远程医疗、健康APP）、公共卫生监测和应急能力提升
2. **消极影响**：屏幕久坐行为增加（“电子久坐”）、互联网成瘾、睡眠紊乱（蓝光暴露）、信息误导（伪健康信息传播）、隐私泄露和基因歧视风险

6.5 风俗习惯对健康的影响

1. **有益健康的风俗**：中国传统饮食文化（均衡搭配、食疗养生）、饮茶习惯（抗氧化）、传统体育运动（太极拳、八段锦等）
2. **有害健康的风俗**：某些地区的嚼槟榔习惯（口腔癌风险）、高盐腌制食品消费（高血压、胃癌风险）、女性割礼（FGC）等陈规陋习
3. **需科学引导的风俗**：坐月子、特殊饮食禁忌等需结合现代医学知识加以科学化引导

6.6 宗教与道德对健康的影响

6.6.1 宗教

1. **积极方面**：提供精神慰藉和心理支持 → 减轻焦虑和抑郁；宗教倡导健康生活方式（禁止酗酒、暴饮等）→ 减少危险行为；宗教团体提供社会网络和支持；宗教教义中的积极心理暗示
2. **消极方面**：某些宗教习俗可能延误医疗救治（拒绝输血、拒绝接种疫苗等）；宗教狂热可能导致社会冲突和暴力；特定宗教规定可能影响营养和身体健康

6.6.2 道德

道德规范通过调节人们的社会行为间接影响健康：促进利他行为和互助 → 增强社区凝聚力和社会支持；约束危险行为（如对吸毒、酒驾的道德谴责）；医德伦理直接关系到医疗质量和患者健康。

6.7 非主流文化对健康的影响

[概念] 概念释义：非主流文化（亚文化与反文化）：与主流文化价值观念和行为规范相区别甚至相对立的文化形态和生活方式。

1. **亚文化群体**可能有特殊的健康风险：某些青年亚文化中药物滥用、危险性行为等风险较高
2. **反文化**可能与主流卫生倡导相抵触（如“反疫苗运动”）
3. 需关注文化适应（Acculturation）对移民群体健康的影响——文化冲突和文化适应压力可能导致心理问题

6.8 复习题

一、选择题

1. 文化影响健康的特点不包括：
(A) 潜移默化性
(B) 短暂易变性
(C) 广泛渗透性
(D) 双重性
2. 以下哪项不是教育影响健康的机制？
(A) 提高健康素养
(B) 改变遗传特征
(C) 促进健康行为
(D) 改善职业和经济地位
3. 受教育程度对以下哪一人群的健康影响最为显著？
(A) 成年男性
(B) 母亲（对儿童健康）
(C) 老年人
(D) 青少年

二、名词解释

1. 文化（Culture）
2. 文化适应（Acculturation）
3. 亚文化（Subculture）

三、简答题

1. 试述文化对人群健康影响的作用模式。
2. 简述文化影响健康的特点。
3. 简述教育影响健康的机制。
4. 举例说明风俗习惯对健康的影响（正反两方面）。

参考答案要点

一、选择题

1. (B)；2. (B)；3. (B)

二、名词解释

1. **文化：**广义指人类创造的物质和精神财富总和；狭义（社会医学关注）指社会意识形态及与之相适应的制度和组织机构，包括思想观念、价值体系、道德规范等精神文化要素。
2. **文化适应：**不同文化群体在持续接触过程中发生的一方或双方原有文化模式变化的现象，移民群体的文化适应对其健康有重要影响。
3. **亚文化：**社会某一群体特有的、区别于主流文化的文化模式和行为方式。

1. 价值观: 人认定事物、辩定是非的一种思维或取向。 [?] 乐观积极向上人生观:良好的健康状态 [?] 享乐价值观:享乐型的生活方式, 与现代“文明病”有关
2. 健康意识和健康信念 [?] 健康意识:对健康及有关问题的感悟和知觉。 [?] 健康信念:是人们对健康的基本看法和观点。
- 3.个人控制信念: 是指个体对自己所面对的问题或情景所持的控制信念。
- 应激的结果
- [?] 适应, 保持内环境稳态, 并调整自己的情绪、认 知、行为, 使之最终适应社会生存。 [?] 适应不良, 产生身心疾病。
- 持久过大压力的不良后果
1. 健康问题:压力过大可以引起各类疾病, 如高血压、偏头疼、癌症、溃疡、关节炎、心血管病等。过度压力还可引起心理和行为问题, 如心理障碍、吸烟、酗酒、自杀和反社会行为等。
2. 工作问题:压力过大导致旷工、消极怠工、缺乏责任心, 工作差错和事故增加。压力给美国造成的损失每年3050亿美元
3. 管理和决策问题: 出现决策失误:[?] 建设性思维减少, 扭曲性思维增加 [?] 危险性抉择和非理智行为可能性增加 [?] 重视短期目标, 忽略长远目标 [?] 做出不成熟甚至错误决策的可能性增大

7.1 心理因素与健康

7.1.1 人格与健康 是稳定地表现于个体的心理 特质, 由遗传和环境共同决定, 对人的社会化过 程的作用举足轻重。

[概念] 概念释义: 人格 (Personality): 个体在遗传基础上, 通过与后天环境的交互作用而形成的相对稳定、独特的心理行为模式的总和。

! 重点掌握: 人格与健康的关系——三种典型人格类型:

表 7-1 人格类型与健康的关系

类型	特征	健康风险
A 型人格	竞争性强、时间紧迫感、敌意和攻击性	冠心病的独立危险因素, 风险为 B 型的 2 倍
B 型人格	悠闲自得、从容不迫、不易紧张	健康保护因素
C 型人格	过度克制、压抑情绪、顺从忍让	可能与癌症发生和进展有关

7.1.2 认知与健康

[概念] 概念释义: 认知 (Cognition) 是人们对客观事物进行信息加工的认识过程, 包括感觉、知觉、记忆、思维、想象和语言等。认知方式影响人们对健康信息的获取、理解和运用, 以及疾病应对策略的选择。

是指人们的认识活动或认识过程, 包括信念、思维和想象等。

7.1.3 心理压力与健康 (教学难点 *)

! 重点掌握: (教学难点 *) 心理压力 (Psychological Stress) 的基本理论:

- 1.生物应激理论 应激反应:生物体对某些情景自动的或激素反应。 压力(克劳德):机体对外界刺激所做出的适应性反应。
- 2.社会事件刺激理论 压力(坎农):外部压力事件的刺激作用。
- 3.心理认知理论: 拉扎勒斯和福尔克曼强调人们对刺激事件的认知和解释的重要性。
- 4.现代压力理论: 国内学者倾向于将心理应激看作是由各种刺激事件(应激源)到应激反应的多因素作用过程, 即“应激过程模型”。
- 应激源分类:
- 1.躯体性应激:直接对机体作用的刺激物 2.心理性应激源:包括人际冲突、个体的强烈需求、能力不足与过高期望的矛盾等。
- 3.社会性应激源:客观的社会学指标, 社会性变动与社会地位的不合适
- 4.文化性应激源:因语言、风俗和习惯的改变而引起应 激
- 不同个性特征的人们可以对应激刺激做出不同的 认知评价, 从而趋向于采用不同的应对方式和利用 不同的社会支持, 导致不同的应激反应。

压力(stress)是描述系统负载的一般概念, 最早 源于物理学研究。

7.2 健康相关行为 心理压力在医学上又称为心理应激, 是指人们生活中的各种刺激事件(应激源)和内在要求在心理上所构成的困惑或威胁, 表现为心身紧张或不适。

7.2.1 行为与健康相关行为

[概念] 概念释义：行为（Behavior）：个体在内外环境刺激作用下产生的可观察的反应和活动。

健康相关行为（Health-related Behavior）：个体或群体与健康 and 疾病有关的行为。分为两类：

- 促进健康行为（Health-promoted Behavior）：有利于健康的行为，如合理饮食、定期锻炼、规律作息、遵医行为等
- 危害健康行为（Health-risky Behavior）：不利于健康或导致疾病的行为，如吸烟、酗酒、吸毒、不合理饮食、缺乏运动等

促进健康行为的基本特征(补充)

-有利性:行为表现有益于自己、他人和全社会

-规律性:行为表现有恒常的规律

-和谐性:个体行为表现有自己鲜明的个性，又能根据整体环境随时调整自身行为

-一致性:行为本身有外显性，但它与内心是一致的 -适宜性:行为强度有理性控制，无明显的冲动表现

7.2.3 健康行为的观点与理论（教学难点*）

！重点掌握：（教学难点*）健康行为改变的主要理论：

1. 知信行模式（Knowledge-Attitude-Behavior Model, KAB/KAP）：

- 知识（Knowledge）→ 信念/态度（Attitude）→ 行为（Behavior）
- 认为健康知识是形成正确健康信念和态度的基础，健康信念和态度是行为改变的动力
- 局限性：知信行过程不是简单的线性关系，存在“知行不一”现象

2. 健康信念模型（Health Belief Model, HBM）：

由 Rosenstock 等提出，认为人们采取健康行为取决于以下五个因素：

1. 感知到易感性（Perceived Susceptibility）：认为自己可能患某种疾病
2. 感知到严重性（Perceived Severity）：认为疾病会带来严重后果
3. 感知到益处（Perceived Benefits）：认为采取健康行为有好处
4. 感知到障碍（Perceived Barriers）：认识到采取健康行为的障碍和代价
5. 行动线索（Cues to Action）：激发行为改变的内外提示

3. 阶段变化理论（Transtheoretical Model, TTM）：

由 Prochaska 和 DiClemente 提出，行为改变经历五个阶段：

1. 无意图期（Precontemplation）——未考虑改变
2. 意图期（Contemplation）——开始考虑改变
3. 准备期（Preparation）——准备采取行动
4. 行动期（Action）——已开始改变行为
5. 维持期（Maintenance）——持续保持新行为

4. 计划行为理论（Theory of Planned Behavior, TPB）：

行为意向受三个因素影响：行为态度；主观规范；知觉行为控制。

7.3 行为心理问题的干预

1. 健康教育与健康促进：提高健康素养，传播健康知识，塑造积极态度和行为
2. 认知行为治疗（CBT）：改变不良认知模式和行为习惯
3. 行为矫正（Behavior Modification）：运用正负强化、替代学习等手段
4. 环境干预：改变社会环境以支持健康行为（无烟区、健康食堂等）
5. 政策法规干预：立法限制危害健康行为（公共场所禁烟、酒驾处罚等）
6. 社区干预：以社区为基础的综合行为干预项目

7.4 吸烟与控烟

一、政策干预

☐ 政策干预是效益很高的措施。如公共场所禁烟 计划、禁止吸烟广告。

☐ 政府是政策制定的主体，需要通过政策倡导促 动来促使政府采纳和实施有利于人民健康的政 策。

☐ 倡导促动是指向目标组织或个人提出主张并促使其采 纳的行动。

包括四要素:倡议—联盟—宣传—行动，即 **PCPA**模 式

倡议—提出议题；

联盟—建立伙伴关系，并进行运作

宣传—公开意图，设计讯息研制和传递

行动—为达到倡导目标而进行的游说和鼓动等活动。

(二)环境工程设施干预：通过改善某种环境工程设施，增加行为相关物的可得性或可及性，以增强行为干预效果。

(三)大众媒体干预：利用媒体影响大众和决策者的知识、观点、态度和行为，如电视、手机、网络等，进行健康教育。

(四)社区干预

☐在社区层面(家庭或社区人群聚集活动的场所) 进行疾病预防、控制、教育和咨询等活动。

☐社区动员是社区干预的前提，即将满足社区居民 需求的社会目标转化成社区成员广泛参与社区行动 的过程。☐居民通过参与健康计划制订、实施和评价等一系 列的活动，不但改善个体或群体的健康状况，还可 以提高认识和解决自身健康问题的能力。

(五)组织干预

☐是通过对不合理的组织结构和行为进行改变， 达到干预目标。

☐可依据组织分阶段改变理论实施干预

☐分为4个阶段:问题知觉、行动启动(采纳)、 实施和定型化。

7.4.1 吸烟的健康危害

1.心脑血管疾病 2.呼吸系统疾病 3.消化系统疾病 4.生殖系统疾病
5. 神经系统疾病 6.内分泌系统疾病

！重点掌握：吸烟是最重要的可预防性致死原因。

- 吸烟与肺癌、COPD、冠心病、脑卒中等 25 种以上疾病密切相关
- 中国是全球最大的烟草消费国和生产国，吸烟人数约 3.5 亿
- **二手烟（被动吸烟）**同样严重危害健康，无“安全”暴露水平
- **三手烟（环境烟草烟雾残留）**也存在潜在健康危害
- 每年全球约 800 万人死于烟草相关疾病（其中约 100 万死于被动吸烟）

7.4.2 控烟的政策措施

1. **WHO《烟草控制框架公约》(FCTC)**——首个国际公共卫生条约（2003 年通过）
2. **MPOWER 六大控烟策略**（WHO，2008 年）：
 - **Monitor**——监测烟草使用和预防政策
 - **Protect**——保护人们免受烟草烟雾危害（无烟环境立法）
 - **Offer**——提供戒烟帮助
 - **Warn**——警示烟草危害（图形健康警示标签）
 - **Enforce**——禁止烟草广告、促销和赞助
 - **Raise**——提高烟草税和价格（最有效的单项措施）
3. **中国控烟措施：**《烟草控制法》推进、公共场所禁烟令、烟草税上调、烟盒警示标签

7.4.3 控烟倡导运动

[概念] 概念释义：倡导 (Advocacy)：为动员政治和社会力量，推动政策改变和资源分配而采取的有组织的社会行动。控烟倡导通过四个方面——收集证据、建立联盟、媒体宣传、政策对话——推动控烟立法和政策实施。

酗酒(补充)

❓酗酒是指无节制地过量饮酒。

❓酗酒涵盖了“酒精滥用”及“酒精依赖”。

❓一般而言，如果一个人过度使用酒精而无法自我节制，导致认知上、行为上、身体上、社会功能或人际关系上的障碍或影响，就达到“酒精滥用”的程度。

❓若进一步恶化，把饮酒看成比任何其他事都重要，或必须喝酒才感到舒服(心理依赖)，就达到“酒精依赖”的程度。

酗酒的危害

急性:急性酒精中毒、家庭不和、危害社会治安(车祸、暴力)等。

慢性:酒瘾综合征、脂肪肝、肝硬化、酒精性脑病、心血管疾病、神经精神疾病等。

身体活动(补充)

❓身体活动系指由骨骼肌肉产生的需要消耗能量的任何身体动作。

❓目前，世卫组织的建议是，人们每周至少从事 150 分钟的中等强度身体活动，或 75 分钟的高强度身体活动，低于这个标准的人即被认为是身体活动不足。

身体活动不足的危害

❓身体活动不足(缺乏身体活动)被认为是全球第四大死亡风险因素(占全球死亡人数的 6%)。此外，据估计，身体活动不足是造成约 21-25% 的乳腺癌和结肠癌、27% 的糖尿病和 30% 的缺血性心脏病负担的主要原因。

不安全性行为(补充)

安全性行为是针对如何降低性行为传播疾病的危险而提出的概念，它是指那些既能降低性传播疾病的危险又能满足性需求的行为。

不安全的性行为就是指没有使用避孕或是抗性病措施情况下进行的性行为。

不安全性行为的危害

❓就产生疾病负担的危险因素而言，不安全性行为被列为 10 大因素的第 3 位，其根本原因就是不安全性行为会导致艾滋病。除此以外，不安全性行为还可能会导致梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体感染、尖锐湿疣、生殖器疱疹等 50 余种性传播疾病。

(一)调查研究：在一特定现场的人群中，采用一定的工具和手段收集研究所需资料的一种方法。
[?] 分类:按收集资料方法分:访谈法、信访法、观察法等；按所获资料性质分:定量调查和定性调查；按调查对象范围分:全面调查(普查)和非全面调查(抽样调查)；按调查时间序列分:回顾性调查、前瞻性调查
(二)实验研究现场实验研究:又称社区干预实验，是指在人群中，施行某种卫生措施，与对照人群(不采取干预措施)进行比较，观察该措施对人们的行为和健康状况的影响的一种方法。
(三)评价研究1.生命质量评价 2.健康危险因素评价 3.卫生服务评价 4.卫生项目评价
(四)德尔菲法[?] 核心是通过多轮函询征求专家对某一问题的意见。[?] 卫生政策与策略综合评价中评价指标的选择、指标权重 的确定。
(五)文献研究：文献研究是利用已有的资料，通过综合整理、分析、归纳等手段最终达到研究目的一种研究方法。| 文献研究是研究的“前奏”。确定课题，设计方案。| 某些研究的主要手段。

8.1 社会医学研究概述

8.1.1 社会医学的相关研究方法

社会医学研究综合运用多种研究方法：

- 1. 调查研究法——最常用的方法，包括问卷法、访谈法、观察法等
- 2. 文献研究法——系统查阅和分析已有文献资料
- 3. 实验研究法——社会干预实验、健康教育效果评价等
- 4. 比较研究法——不同人群、地区、时期之间的比较
- 5. 综合评价法——健康危险评价、生命质量评价、卫生服务综合评价等

8.1.2 社会医学研究的步骤

社会医学研究的五个步骤

1. 选题与确定研究问题——根据实际需求、资料可及性和研究条件提出明确的研究问题
2. 制定研究设计/方案——包括研究目的、对象、方法、资料收集和分析方案、时间进度、经费预算等
3. 收集资料——通过问卷、访谈、观察、文献等方式收集原始资料和二手资料
4. 整理和分析资料——定性资料和定量资料的整理、编码、统计分析或内容分析
5. 撰写研究报告——研究报告的规范格式包括前言（问题背景）、研究设计和实施、结果、讨论与建议

8.1.3 课题评价三原则

！重点掌握：课题评价的三个基本原则：

1. 需要性原则——研究问题应满足社会卫生实践的需要或理论发展的需要，解决实际问题
2. 创新性原则——研究问题应有一定的新颖性，在前人研究基础上有所突破或创新
3. 科学性原则——研究问题应具备科学依据和理论支撑，方法科学、设计合理

此外，还应考虑可行性原则——研究目标在现有条件下（人力、物力、财力、时间等）是否可以实现。

8.1.4 抽样方法概述

抽样方法的两种类型

概率抽样（Probability Sampling）——按概率均等原则抽取样本，代表性好，可用于统计推断：

- 单纯随机抽样（Simple Random Sampling）
- 系统抽样（Systematic Sampling）
- 分层抽样（Stratified Sampling）
- 整群抽样（Cluster Sampling）
- 多阶段抽样（Multi-stage Sampling）

非概率抽样（Non-probability Sampling）——不按概率均等原则抽取样本，在定性研究中广泛应用，详见下表。

8.1.5 非概率抽样

[概念] 概念释义：非概率抽样（Non-probability Sampling）：不按概率均等原则抽取样本，而是根据研究者的主观判断或便利条件选择研究对象。在社会医学的定性研究中广泛应用。

四种主要类型：

表 8.1: 非概率抽样方法比较		
方法	定义	特点与适用
方便抽样（Convenience/Accidental Sampling）	选择最方便接触到的研究对象	简单易行但代表性差；适用于初步探索和预调查
立意抽样（Purposive/Judgmental Sampling）	根据研究者判断和目的选择有代表性的对象	灵活但主观性强；适用于了解典型个案
滚雪球抽样（Snowball Sampling）	从已知研究对象开始，由他们推荐符合条件的新研究对象	适用于难以找到的”隐藏人群”（如静脉吸毒者、性工作者等）
定额抽样（Quota Sampling）	按某些特征将总体分层后非随机抽取各层样本	在各层按比例抽取，但各层内非随机；可用于快速调查

8.2 定性研究

[概念] 概念释义：定性研究（Qualitative Research）：通过与研究对象的深入互动来理解人们的行为、观点、经验和感受，获取深层次信息的研究方法。研究结果以文字描述形式呈现。

特点：

长期随访
定性研究

1. 注重对事物的深层理解和”意义”的挖掘
2. 研究设计灵活，可在研究过程中调整
3. 样本量较小，采用非概率抽样
4. 资料收集以开放式交流为主
5. 结果难以推广到大范围人群，但具有深刻性

质性研究。是一种在自然的情境下，从整体的角度深入探讨和阐述被研究事物的特点及其发生和发展规律，以揭示事物的内在本质的一类研究方法。收集这类资料的调查称为定性调查。

8.2.1 常用定性研究方法

！重点掌握：四种主要定性研究方法：

1. 深入访谈法（In-depth Interview）：

- 访谈者与受访者一对一深入交谈
- 按事先准备的访谈提纲进行
- 开放式问题，鼓励受访者自由表达
- 时间：通常 30 分钟-2 小时
- 适用于：敏感问题、复杂问题的深入探讨

2. 焦点组讨论（Focus Group Discussion, FGD）：

- 8-12 人为一组，在主持人引导下围绕特定主题进行讨论
- 利用群体互动激发观点和见解
- 时间：通常 1-2 小时
- 优势：高效、经济，群体互动产生丰富信息
- 劣势：个别个体可能主导讨论，敏感问题不适合
- 案例：一项研究进行了 18 场共 10 小时的焦点组讨论

3. 提名小组讨论（Nominal Group Discussion）：

- 结构化较强的定性方法
- 成员先独立书面回答问题，再依次分享、讨论、排序
- 减少了群体压力和个别主导问题

4. 观察法（Observation）：

定性研究的应用

1、用于帮助问卷设计

2、验证因果关系，探讨发生机制

3、分析定量研究出现矛盾结果的原因

4. 了解危险因素的变化情况

5. 作为快速评价技术，为其它研究提供信息

- 参与式观察——研究者融入被研究群体
- 非参与式观察——研究者保持客观旁观
- 适用于研究实际行为（而非口头报告的行为）

8.2.2 定性研究资料的处理与分析

1. 将录音/录像资料转录为文字
2. 反复阅读资料，熟悉内容
3. 编码——对资料进行主题分类编码
4. 提取主题——归纳核心主题和模式
5. 解释和分析——结合理论框架进行深度解读
6. 撰写报告——用引语（受访者原话）支撑分析结果

8.3 定量研究

通过调查收集人群发生某种事件的数量指标，如患病率、就诊率等，或者探讨各种因素与疾病、健康间的数量依存关系的研究称之为定量研究，其收集资料的过程称为定量调查。

[概念] 概念释义：定量研究（Quantitative Research）：通过收集和分析数量化资料来检验假设、描述事物特征和因果关系的研究方法。研究结果以数值形式呈现，可进行统计分析。

特点：

1. 研究设计结构化、标准化程度高
2. 样本量大，采用概率抽样
3. 资料以数字形式收集和分析
4. 结果可推广到目标总体
5. 强调客观性和可重复性

优点1)重点在研究假设，逻辑推理比较严谨；2)标准化和精确化程度较高；3)可以用概率统计的方法检验；4)具有较好的客观性和科学性
局限1)投入较大；2)难获得对事物深层次或意料之外的信息；3)一些社会因素及医学问题难以用数据指标表达；4)一些社会因素与健康及疾病的关系很难用定量结果解释。

8.3.1 访谈法与自填法

！重点掌握：访谈法（Interview Method）与自填法（Self-administered Method）的比较：
表 8-2 访谈法与自填法的优缺点比较

比较维度	访谈法	自填法
优点	(1) 应答率高；(2) 可获得较高质量资料；(3) 可观察受访者表情反应；(4) 可辅助解释和澄清问题	(1) 省时省力，成本低；(2) 可匿名填写，适用于敏感问题；(3) 无访谈者偏倚；(4) 可大规模同时进行
缺点	(1) 费时人力成本高；(2) 访谈者偏倚；(3) 匿名性差；(4) 受访者可接触的样本量受限	(1) 应答率低；(2) 不能解释和澄清问题；(3) 无法确定填写者；(4) 问题顺序可能被跳过

8.4 问卷设计

8.4.1 问卷的概念、类型和结构

问卷或称调查表、量表，是指有详细问题和可供选择的答案或只有问题而无答案的可用来提问收集资料的工具。

[概念] 概念释义：问卷（Questionnaire）：由一系列与研究目标相关的问题组成的调查工具，用于系统地收集研究对象的特征、行为、态度、知识等信息。

问卷类型：

- 按填写方式：自填式问卷、访谈式问卷
- 按发放方式：现场问卷、邮寄问卷、网络问卷、电话问卷

问卷结构：

1. 封面信/卷首语——说明调查目的、意义、保密承诺、填写方法、致谢
2. 指导语——具体说明如何填写和回答问题
3. 问题与答案——问卷的主体部分
4. 编码——便于计算机录入和分析

↓ 问卷问题答案 ↓ 特征、行为、态度

- ❑ 答案的设计应考虑被调查者是否能方便地回答
- ❑ 开放式问题不需要列出答案，在设计时只须在问题下面留够空白即可
- ❑ 封闭问题要提供多个备选答案，答案格式设计较为复杂

问卷设计原则

❑ 目的原则:问卷中的每一个问题都应与研究目的相关，通常不应该包括那些无关的问题

❑ 实用性原则:用词简明清楚、准确，描述应具体而不抽象，避免专业性术语或俗语，回忆时间不宜过长，一般不能有计算的内容

❑ 反向性原则: 问卷中的问题，是在考虑了最终想要得到的结果的基础上反推出来的。

问卷设计的步骤1. 明确研究的目的2. 建立问题库(1)头脑风暴法(2)借用其它问卷的条目3. 设计问卷初稿4. 试用和修改5. 信度与效度的检验

→ 定稿印刷

完善

1. 开放式问题：指那些只有提问，而没有提供备选答案、被调查者可自由回答的问题
- 优点:❑ 可用于不知道问题答案有几种的情况❑ 能收集到更多的反映被调查者特征的资料❑ 回答者可按自己喜欢的方式、不受限制、灵活地回答提问❑ 当一个问题的答案过多时，如超过10种，宜用开放式问题
- 缺点❑ 可能得到一些与研究无关的信息❑ 要求回答者有一定的文化水平和语言表达能力❑ 需花费较多的时间和精力❑ 应答率低❑ 统计分析处理困难
- 封闭式问题❑ 在提问同时,提供两个及以上的备选答案,要求回答者按要求从中选择适合自己的答案❑ 提供备选答案应遵循独立原则和穷尽原则❑ 一般提供的答案要使大部分(至少80%)回答者能找到自己的答案
- 优点:❑ 容易回答，节省时间，拒答率低，应答率高❑ 低文化程度者也能回答，适用范围较广❑ 敏感的问题用等级资料的方式让回答者选择，更能获得相对真实的回答❑ 便于统计分析处理
- 缺点:❑ 有猜答和随便回答的可能❑ 答案有时设计不易作到穷尽❑ 对于问题的了解难以深入❑ 容易发生笔误

8.4.4 问卷设计常见错误及注意事项

[提示] 要点提示：问卷设计常见的错误：

- 1. 双重问题（Double-barreled Question）——一个问题包含两个以上询问内容
- 2. 诱导性问题（Leading Question）——问题措辞暗示了期望的答案
- 3. 专业术语过多——受访者难以理解
- 4. 问题含糊不清——不同应答者理解不一致
- 5. 选项不互斥或不穷尽——答案选项设计缺陷
- 6. 回忆性偏倚——要求应答者回忆太久远的事情
- 7. 敏感问题放置不当——引起应答者防御心理

问题排列顺序原则：

- ❑ 先易回答问题，后难回答问题
- ❑ 封闭式问题列在前面，开放式问题列在后面
- ❑ 问题排列要有一定的逻辑顺序
- ❑ 检验信度的配对问题须分隔开来

1. 答案格式种类

- ❑ 填空式:常用于事实性的、能定量的问题
- ❑ 二项选择式:在问题陈述后提供的是两个相互排斥的答案
- ❑ 多项选择式:答案数目超过两个
- ❑ 图表式:其中线性尺度和表格用得最多
- ❑ 排序式

8.5 效度与信度

8.5.1 效度的概念与类型（教学难点*）

[概念] 概念释义：效度（Validity）：（教学难点*）指测量工具或手段能够准确测出所需测量的事物的程度，即“测的是否正确”（准确性）。与目标接近程度、评价偏倚、测量真实性

效度的四种类型：

- 1. 表面效度（Face Validity）：从表面上主观判断测量工具是否看起来测量了所要测的内容。是最基本层次的效度，非正式评估
- 2. 内容效度（Content Validity）：测量工具的内容是否全面、均衡地涵盖了所要测量的概念领域。通过专家评定来判断
- 3. 效标效度（Criterion Validity）：用测量工具的测量结果与某个效标（金标准）进行比较的一致性程度。分为：
 - 同时效度（Concurrent Validity）——与同时测量的效标比较
 - 预测效度（Predictive Validity）——与将来测量的效标比较

4. **结构效度 (Construct Validity)**: 测量工具实际测量到的理论结构和特质与假设的理论结构相符合的程度。是最深层次的效度

分解后形成相应结构

8.5.2 信度的概念与类型 (教学难点 *)

[概念] 概念释义: 信度 (**Reliability**): (教学难点 *) 指采用同一方法对同一对象重复测量时所得结果的一致性程度, 即“测量结果的一致性 or 稳定性” (可靠性)。

信度的四种类型:

1. **重测信度 (Test-Retest Reliability)**: 同一量表对相同对象在不同时间重复测量, 两次结果的相关性。间隔时间不宜过短 (记忆效应) 或过长 (真实变化)
2. **复本信度 (Parallel-Forms Reliability)**: 两个等价的测量工具版本对同批对象测量的结果一致性
3. **折半信度 (Split-Half Reliability)**: 将量表问题分为两半 (如奇数题和偶数题), 计算两部分得分的一致性
4. **内部一致性信度 (Internal Consistency Reliability)**: 量表各条目测量同一概念的程度, 常用 **Cronbach's α 系数** 衡量, $\alpha \geq 0.70$ 为可接受, $\alpha \geq 0.80$ 为良好

8.5.3 信度与效度的关系 (教学难点 *)

! 重点掌握: (教学难点 *) 信度与效度的关系:

核心关系: 信度是效度的必要条件, 但不是充分条件。

1. **信度高, 效度不一定高**——测量结果可能稳定但测的不是想要测量的内容 (如用体重秤来“测量”身高——每次都得到一致的结果, 但数值是错的)
2. **效度高, 信度一定高**——如果测量工具确实测量了想测的内容, 那么结果必定是可重复和稳定的
3. **信度低, 效度一定低**——测量结果本身不稳定、不可靠, 就不可能有准确的测量
4. **效度低, 信度不一定低**——可能稳定地测到了别的内容

形象的比喻: 打靶

- **高效度高信度**: 弹孔集中 (信度高) 在靶心 (效度高)
- **高信度低效度**: 弹孔集中 (信度高) 但偏离靶心 (效度低)
- **无信度无效度**: 弹孔分散且偏离靶心——测量无价值

[提示] 要点提示: 如何在研究中保证信度和效度:

- 严格的研究设计和标准化操作流程
- 预调查和预测试, 检验测量工具的信度和效度
- 访谈员培训和质量控制
- 使用广泛验证过的标准化量表
- 三角验证 (Triangulation) ——多种方法和来源的数据相互验证

8.6 复习题

一、选择题

1. 以下哪种抽样方法属于非概率抽样?
 - (A) 单纯随机抽样
 - (B) 系统抽样
 - (C) 分层抽样
 - (D) 滚雪球抽样
2. 用于测量量表各条目测量同一概念程度的信度指标是:
 - (A) 重测信度
 - (B) 复本信度
 - (C) 内部一致性信度
 - (D) 折半信度
3. 关于信度与效度的关系, 以下哪项是正确的?
 - (A) 信度高, 效度一定高

(一)描述性研究:用以阐明卫生服务或健康事件在人群中的分布状况及其变化规律。描述性研究可从以下三个方面进行:•考察卫生服务发展的变动规律,预测卫生事业发展的趋势•比较不同国家或地区卫生服务状况及水平•分门别类地研究卫生事业的特点,评价卫生服务的效益

(二)分析性研究•研究影响卫生服务的因素•单因素或多因素统计分析方法•对列研究 和疾病对照研究

(三)实验性研究•以社区人群作为试验观察对象,考察卫生服务和疾病防治对策的效果。•干预试验,即在人群中增加某些措施或限制某些因素后,观察其效果。

四)数学模型研究:应用数学模型从理论上阐述卫生服务与有关因素的联系及规律,主要描述各变量间的函数关系,如人口预测模型、疾病分布概率模型、卫技人员需要量及病床需要量预测模型等。

(五)系统分析法:运用系统思想分析问题、解决问题的方法。运用系统分析技术,综合分析卫生服务系统各个因素之间的联系,提供若干种备选方案,进行可行性评价和优化选择。如系统动力学方

(六)综合评价法:将卫生服务中有关人群健康状况、医疗需要量、卫生资源和卫生服务利用指标体系及其相互联系进行综合分析,并与相应的参照水平进行比较,以评价卫生服务资源分配和机构布局的合理性。

(七)投入产出比较评价:研究卫生服务投入量(如人力、物力、财力)与产出量(居民对该项服务的享受或利用程度与促进健康方面的效果)之间的数量关系。成本一效益,成本一效果,成本一效用

(八)家庭健康询问抽样调查•以家庭为单位综合性的健康询问抽样调查•从需方的角度研究卫生服务的需要、需求、服务利用及费用等。•分类:一次性横断面抽样调查:重复性横断面调查,连续性横断面调查

[概念] 概念释义:卫生服务研究(Health Services Research): (教学难点 *)是从社会学、管理学、

从卫生服务的供方、需方和第三方及其相互关系出发,研究卫生系统为一定的目的合理使用卫生资源,向居民提供预防、保健、医疗、康复、健康促进等卫生服务的整个过程。

9.1.1 卫生服务研究的意义与目的

1) 提高卫生服务普及程度和居民接受卫生服务能力,即保证 卫生服务利用的公平性; 2) 控制医药费用,提高卫生服务的社会效益和经济效益; 3) 改进卫生服务质量,提高居民健康水平与生活质量。
为了科学合理组织卫生事业,以有限的卫生资源尽可能满足广大居民的卫生服务需要,提高居民的健康水平和生活质量,改善社会卫生状况。

9.1.2 我国卫生服务研究的进展

- 1、卫生服务研究在全国得到开展
- 2、卫生服务研究范畴、内容和对象进一步拓展
- 3、卫生服务调查研究方法向多样化发展
- 4、多学科融合参与卫生服务研究格局形成

9.1.3 卫生服务研究的内容

- 1, 社会因素对卫生系统的影响: 社会因素对卫生系统有重要影响、有时甚至是决定性的影响。合理组织卫生服务、充分发挥卫生资源的作用是组织卫生服务体系的基本原则。
- 2、评价人群医疗卫生服务需要: 了解人群认识到的和潜在的卫生服务需要量及其影响因素是卫生服务研究的重要内容。研究人群卫生服务需要量不能满足的程度和影响因素,可以为改善卫生服务指明方向和重点。
- 3、卫生资源的合理配置和有效使用: 卫生资源: 开展各种卫生服务所需要的社会资源的总和,包括包括: 卫生人力、财力、物力以及技术和信息等要素。以提高人群健康水平为中心,以满足社会需求为导向,合理配置卫生资源,以提高资源的利用率和公平性。
- 4、卫生系统的组织结构与功能: 如何审时度势、因地制宜地建立健全。卫生服务体系和工作网络,提出协调的方法和手段,以及在提供卫生服务的内容、性质、范围及层次方面,有大量值得研究的课题。
- 5 卫生系统的经济分析: 卫生经费是开展卫生服务活动的必要条件。卫生经费的研究。其来源、数量、分配、使用及其构成,是卫生管理者和决策者不可缺少的基础信息和数据。
- 6.卫生服务效果评价: 人群健康状况是评价卫生服务效果的最终指标。

9.2 卫生服务需要、需求与利用

卫生服务要求反映居民要求预防保健、增进健康、摆脱疾病、减少致残的主观愿望,不完全是由自身的实际健康状况所决定。- 公众对卫生相关部门的希望、要求和建议- 专项调查

卫生服务需要need依据人们的实际健康状况与“理想健康水平»之间存在差距而提出的对医疗、预防、保健、康复等服务的客观需要。

卫生服务需求demand从经济和价值观念出发,指在一定时期内,一定价格水平上人们愿意而且有能力购买的卫生服务量。-由需要转化而来的需求-没有需要的需求

卫生服务利用utilization是需求者实际利用卫生服务的数量⁴⁴(即有效需求量), 是人群卫生服务需要量和卫生资源供给量相互制约的结果。直接描述卫生系统为居民提供卫生服务的数量和工作效率。(如门急诊人次)

卫生服务需要与利用指标的应用

- 1.测算目标人群卫生服务需要量和利用量：两周调查结果可以推算全年的需要量和估计总体的情况，为制定卫生规划提供重要依据。•两周平均指标值乘26
- 2. 为合理配置卫生资源提供依据•根据患病人数、日数计算门诊需要量：根据患病人数、卧床人数及日数计算住院需要量及人力、病床需要量等。
- 3. 计算疾病造成的间接经济损失，确定重点干预疾病•以每人每年误工天数乘以人均产值或人均工资，再乘以该地区总人口数，得出因病误工引起经济损失。

注意事项：

- 基本医疗卫生服务
- 特殊医疗卫生服务
- 短期卫生发展计划
- 长期卫生发展规划

需要、需求、利用三者的关系：

- 1. 需要 需求：有需要的人不一定有需求（如因经济困难、交通不便未就医）；有需求的人不一定有需要（如不必要的体检和药品需求——”诱导需求”）
- 2. 需求 利用：有需求的人可能因各种障碍（等待时间过长、交通不便等）未能实际利用服务
- 3. 需要 → 需求 → 利用是医疗服务转化的理想路径，但转化过程中存在多种障碍
- 4. 未满足的需要（Unmet Need）：有卫生服务需要但没有转化为需求和利用，是需要重点关注的问题

9.2.2 影响卫生服务需要与利用的因素

- 1. 人口学特征：年龄（老年人和儿童需要更多服务）、性别（女性利用率较高）
- 2. 社会经济因素：收入水平（低收入人群未满足需要更多）、教育程度、职业、医疗保险覆盖
- 3. 健康状况：患病率和疾病严重程度是决定需要的最基本因素
- 4. 卫生服务供给：服务的地理可及性、服务质量、价格和等待时间
- 5. 文化和信念：对健康和疾病的文化认知、就医观念和习惯
- 6. 政策与制度：医疗保险制度、转诊制度、支付方式等政策因素

9.2.3 常用指标

表 9.1: 卫生服务需要与利用常用指标

指标类型	具体指标
卫生服务需要指标	两周患病率 = 两周内患病人数/调查人数 × 100%；慢性病患病率；健康自评状况；疾病频率指标
门诊服务利用指标	两周就诊率 = 两周内就诊人数/调查人数 × 100%；年人均就诊次数；未就诊率及未就诊原因分析
住院服务利用指标	住院率 = 一年内住院人数/调查人数 × 100%；人均住院天数；应住院未住院率及原因
预防保健利用指标	计划免疫覆盖率、产前检查率、住院分娩率、健康体检率等

9.3 卫生资源

卫生资源：开展各种卫生服务所需要的社会资源的总和，包括卫生人力、卫生费用、卫生设施、卫生装备和药品、卫生信息、卫生知识和技术。

[概念] 概念释义：卫生资源（Health Resources）：社会投入到卫生服务中的人力、物力、财力、技术和信息等资源的统称。

9.3.1 卫生人力资源

[概念] 概念释义：卫生人力资源（Health Human Resources）：接受过卫生专业教育和培训，从事卫生服务相关工作的人员的总称。是卫生资源中最核心、最活跃的元素。
研究内容：卫生人力的数量、质量、结构和分布（城乡、地区、机构层级之间）。

卫生人力规划就是对未来人力需要量、拥有量和供需关系的预测，是卫生部门对人力数量和知识、技能类型的预测过程。

- 1. 卫生人力需求(1) 健康需要法根据应该接受的服务项目、服务的数量计算卫生人力需要量。(2) 健康需求法建立在有效需求，即卫生服务的实际利用上。(3) 服务目标法：1名医生1年能提供5000人次门诊服务，则根据门诊服务的总量计算需要医生的量。(4) 人口比值法

- 2. 卫生人力供给量分析，卫生人力供给包括：现有人力拥有量（现有供给量）未来卫生人力增加量（预期增加量）流失量（预期减少量）

- 3.卫生人力管理-制订政策和规范-调节需求-监督和指导-激励-评价

卫生费用研究是研究卫生服务领域内经济活动规律、特点及影响因素。

广义的卫生费用是指在一定时期内为提高人民健康所直接和间接消耗的社会资源，包括一切人力、物力和财力消耗，以货币来计量。

•狭义的卫生费用是在一定时期内为提供卫生服务直接消耗的经济资源。通常所指的卫生费用是指狭义的卫生费用。

卫生费用研究内容：— 需要多少卫生费用—来源和流向—构成和特点—分配和使用的公平性—影响因素—变动趋势

卫生费用的来源和分类

1. 卫生费用主要通过国家、社会和个人三个途径获得。

2、卫生费用的分类(1)按卫生费用消耗方式来划分，卫生费用可以分直接卫生费用和间接卫生费用。

直接卫生费用：国家、社会为提供卫生服务而支付的费用，病人看病所支付的服务费，化验检查费、药费、材料费等，是卫生费用研究的主要内容。

间接卫生费用：因病误工的工资、治病所花的车旅费、亲属照顾病人而误工的工资或收入、因病增加的营养费等等。

(2)从医疗卫生的角度划分，卫生费用可分为医疗服务费、公共卫生服务费、医学教育费和医学科研费等。

9.4 卫生服务的综合评价（教学难点 *）

！重点掌握：（教学难点 *）卫生服务的综合评价模式是将卫生服务需要、卫生资源投入和卫生服务利用三者结合起来进行综合分析的方法。

综合评价矩阵：根据**需要量（高/低）**与**资源投入（高/低）**与**服务利用（高/低）**三个维度的组合，将不同地区分为八种类型：

表 9-2 卫生服务综合评价矩阵

需要	资源	利用	综合评价
高	高	高	A 型——资源充足、利用良好、供需平衡
高	高	低	B 型——资源充足但利用不足，需提高利用效率
高	低	高	C 型——资源不足但利用高，需增加资源投入
高	低	低	D 型——资源不足利用差，需全面加强
低	高	高	E 型——可能存在资源过剩或诱导需求
低	高	低	F 型——资源过剩但利用不足，效率低下
低	低	高	G 型——资源低但利用相对好，效率尚可
低	低	低	H 型——需要、资源、利用均低，视情况调整

综合评价的意义：

1. 帮助发现不同地区卫生服务的主要问题和瓶颈
2. 为卫生资源配置和服务规划提供科学依据
3. 综合评价三个维度，避免单一指标的片面评价
4. 适用于地区间比较和不同时期的纵向比较

9.5 复习题

- 卫生费用研究的评价指标
- 1.卫生总费用占国内生产总值百分比
 2. 人均卫生费用
 - 3.政府财政预算卫生支出占卫生总费用百分比
 4. 卫生事业费占财政支出百分比
 - 5.卫生各部门的投资比例
 6. 门诊和住院费用的构成
 7. 医疗、预防、保健服务的比例
 3. 卫生总费用（THE）的来源不包括：
 - (A) 政府卫生支出
 - (B) 社会卫生支出
 - (C) 国际援助

11.1 健康危险因素概述

[概念] 概念释义：健康危险因素（Health Risk Factors）：能使疾病或死亡发生的可能性增加的因素，或者能使健康不良后果发生概率增加的因素。

11.1.1 健康危险因素的分类

健康危险因素的四大分类

1. 环境因素——自然环境（空气、水、土壤污染）；社会环境（经济、文化、教育、社会支持等）
2. 生物遗传因素——遗传易感性、家族史、年龄、性别等
3. 行为生活方式因素——吸烟、酗酒、不合理饮食、缺乏运动、药物滥用等
4. 医疗卫生服务因素——卫生服务可及性、质量、医疗保障覆盖等

11.1.2 健康危险因素的特点

1. 潜伏期长——危险因素暴露后往往经过很长时间才出现疾病后果
2. 联合作用——多种危险因素同时存在的联合作用比单个因素大
3. 广泛存在——危险因素在人群中广泛分布
4. 特异性弱——一种危险因素可与多种疾病相关，一种疾病也可与多种因素相关
5. 可干预性——许多危险因素可以通过行为和环境的改变加以控制和消除

11.1.3 健康危险因素的作用过程

无危险阶段，出现危险因素，致病因素出现，症状出现，体征出现，劳动力丧失

11.2 健康危险因素评价

[概念] 概念释义：健康危险因素评价（Health Risk Appraisal/Assessment, HRA）：研究危险因素与慢性病发病及死亡之间数量依存关系及其规律性的一种技术方法。通过收集个体生活方式、健康检查、家族史等信息，定量评估个体在未来一定时期内发病或死亡的风险，以及通过改变不良行为而避免或延缓发病或死亡的可能性。

11.2.1 评价步骤（教学难点*）

！重点掌握：（教学难点*）健康危险因素评价的四大步骤：

第一步：收集资料

1. 当地死亡资料——按年龄、性别、死因别死亡率（通常取最近3-5年平均）
2. 个体危险因素资料——通过问卷调查、体格检查和实验室检测获取

选择当地某年龄组最重要的、具有确定危险因素的前10-15种疾病。

目的：(1)确定危害严重的疾病(2)作为评价标准

个人健康后险因素资料途径：（1）问卷调查法

（2）询问疾病史（3）体格检查（4）实验室检查

内容：（1）行为生活方式（2）环境因素（3）生物遗传因素（4）医疗卫生服务（5）疾病史

分析资料

- 1、将危险因素转换成危险分数（危险因素评价的关键步骤）危险因素相当于平均水平时，其危险分数定为1.0。所谓平均水平即指当地某年龄组某病的平均死亡率。
- 2、计算组合危险分数：①与死亡原因有关的危险因素只有一项时，组合后险分数等于该死因的危险分数②与死亡原因有关的后险因素是多项时：危险分数大于1.0的名项 -1.0) + 危险分数小于或等于1.0的各项相乘
- 3、计算存在死亡危险•存在死亡危险：在某一种组合危险分数下。因某种疾病发生死亡的可能危险性。•计算公式：某种疾病的存在死亡危险= 某种疾病的平均死亡率×该疾病的组合危险分数
- 4、计算评价年龄：根据年龄和死亡率之间的函数关系，按个体所存在的危险因素计算的预期死亡率水平求出的年龄。计算方法：总的存在死亡危险去查评价年龄表。
- 5、计算增长年龄（可达到年龄）：通过努力降低后险因素后可能达到的预期年龄。即根据已存在的危险因素，提出可能降低危险因素的措施后预计的死亡水平求出的评价年龄。•计算方法步骤：
 - ①计算改变危险因素后的危险分数、组合危险分数即得新危险分数、新组合危险分数
 - ②用某种疾病的平均死亡率*该疾病的新组合危险分数得该疾病的新存在死亡后险
 - ③用新存在死亡危险的合计值去查评价年龄表得增长年龄
- 6、计算危险因素降低程度：如果根据医生的建议改变现不的危险因素，危险能够降低的程度。用存在死亡危险降低的百分比来表示。

- **危险降低量** = 评价年龄 - 增长年龄：反映通过行为改变可获得的健康收益

第四步：评价与建议

- 向个体或群体反馈评价结果
- 指出主要危险因素及可改变的方向
- 给出具体的健康促进和疾病预防建议

存在死亡危险 - 新存在死亡危险

总存在死亡危险

11.2.2 健康危险因素的个体评价方法

健康危险因素的个体评价，主要通过比较实际年龄、评价年龄和增长年龄（可达到年龄）三者之间的差别，了解危险因素对寿命可能造成的影响程度及降低危险因素之后寿命可能延长的程度。

方法：比较实际年龄、评价年龄、增长年龄（可达到年龄）三者之间的差别

* 评价年龄>实际年龄：说明被评价者存在的危险因素高于平均水平，死亡概率高于当地同年龄、同性别组的平均水平。

* 可达到年龄与评价年龄之差：说明被评价者采取降低危险因素的措施后可能延长的寿命年数。

根据实际年龄、评价年龄和增长年龄三者之间的关系，可以将个体分为四种类型。

（一）健康型(二) 自创性危险因素型(三)难以改变的危险因素型（历史后险因素类型）(四)一般性危险型（少量危险型）

11.2.3 健康危险因素的群体评价方法

(一) 不同人群的危险程度

健康型—健康组

自创性危险因素型

难以改变的危险因素型

一般型—一般组

(二)危险因素的属性

(三)分析单项危险因素对健康的影响

或比

AF)

3. 潜在寿命损失分析：

- 估计去除某危险因素后可能避免的早死人数和寿命损失年数
- 常用指标：**YPLL（潜在寿命损失年）**、**危险降低程度（Risk Reduction）**
- 危险降低程度 = 评价年龄 - 增长年龄，数值越大说明可干预空间越大

4. **群体干预效果模拟**：模拟不同干预策略下人群健康的改善效果，为公共卫生决策和资源配置提供依据

单项危险因素分析示例：对群体中各危险因素分别计算危险强度（平均评价年龄-实际年龄）、危险频度（具有该因素的比例）和危险程度（危险强度 × 危险频度），以确定**应优先干预的危险因素**。

健康危险因素评价的局限性主要表现为

个体健康危险因素改变与健康结局的预测之间存在的不确定性。

11.3 大数据与健康危险因素评价

- 1. 大数据技术为 HRA 提供更精准的个体风险预测——整合电子健康档案、可穿戴设备数据、基因组学数据
- 2. 机器学习算法可识别传统方法难以捕捉的复杂危险因素交互作用

3. 实时监测和预测健康风险——可穿戴设备 + 手机 APP 的持续健康监测
4. 个性化健康管理——基于个人风险图谱的精准干预建议

11.4 复习题

一、选择题

1. 健康危险因素评价中，基准危险分数为：
(A) 0.5
(B) 1.0
(C) 1.5
(D) 2.0
2. 评价年龄大于实际年龄说明：
(A) 个体危险因素水平低于平均
(B) 个体危险因素水平高于平均
(C) 个体健康状况极好
(D) 无法判断
3. 危险降低量等于：
(A) 实际年龄 - 评价年龄
(B) 评价年龄 - 增长年龄
(C) 增长年龄 - 实际年龄
(D) 增长年龄 - 评价年龄
4. 健康危险因素评价中被评估者分为四种类型，其中“危险因素可改变但尚未改变”的是：
(A) 健康型
(B) 存在少量危险因素型
(C) 存在危险因素但可改变型
(D) 存在大量不可改变危险因素型

二、名词解释

1. 健康危险因素评价 (HRA)
2. 评价年龄 (Appraisal Age)
3. 增长年龄 (Achievable Age)
4. 危险分数

三、简答题

1. 简述健康危险因素评价的四大步骤。
2. 简述健康危险因素个体评价的四种类型。
3. 简述危险分数、评价年龄和增长年龄三者之间的关系。
4. 简述健康危险因素的特点。

参考答案要点

一、选择题

1. (B); 2. (B); 3. (B); 4. (C)

二、名词解释

1. **HRA**: 研究危险因素与慢性病发病及死亡之间数量依存关系的一种技术方法，定量评估个体未来发病或死亡风险及通过行为改变可避免的程度。
2. **评价年龄**: 根据个体危险因素，依据死亡率与年龄的函数关系推算的“相当于某年龄平均水平”的年龄。
3. **增长年龄**: 个体采取控制危险因素措施后可能达到的“相当于某年龄平均水平”的年龄。
4. **危险分数**: 危险因素处于某水平时发生某病死亡的危险与人群平均死亡危险的比值，基准为 1.0。

生命质量与生命数量的关系？生命质量和生命数量是相互联系，相互制约的关系，是人类生存的两个方面。

❓生命数量是生命质量的基础，只有具备一定的生命数量，才可能谈及生命质量。❓两者有时会出现对立。人们可能不得不牺牲一定的生命数量来换取更好的生命质量，反之亦然。

❓生命质量与健康的关系？从广义上讲：生命质量评价的就是健康。❓健康是生命质量的重要构成部分，是生命质量的核心和主要决定因素。

12.1 生命质量的概念与构成

是指以社会经济、文化背景和价值取向为基础，人们对自己的身体状态、心理功能、社会能力以及个人综合状况的感觉体验。

12.1.1 生命质量的概念

生命质量反映了个人期望与实际生活状况之间的差距，该差距越大，生命质量就越差。

[概念] 概念释义：生命质量（Quality of Life, QOL）：由美国经济学家 Galbraith 于 20 世纪 50 年代提出。在社会医学领域，生命质量指不同文化和价值体系中的个体对与其目标、期望、标准以及所关心事情有关的生活状态的体验。

健康相关生命质量（Health-related Quality of Life, HRQOL）：在疾病、意外损伤及医疗干预的影响下，人们的健康状态以及与其经济、文化背景和价值取向相联系的主观体验。

！重点掌握：WHO 对生命质量的定义：
不同文化和价值体系中的个体对与他们的目标、期望、标准以及所关心事情有关的生活状态的体验。包含以下核心要素：

- 主观性——以个体自身体验为核心
- 多维度性——包含身体、心理、社会等多维度
- 文化依赖性——受文化背景和价值观念的影响

12.1.2 生命质量的构成

生命质量的构成维度

WHO 提出 QOL 的六个维度：
生理健康、心理状况、独立能力、社会关系、生活环境、个人信仰或精神寄托。

关于生命质量测定内容的共识：生理问题(症状、疼痛)、功能(活动)、家庭良好适应、精神、治疗满意度、对未来的取向、性及亲密行为、社会功能和职业功能。

12.2 生命质量的评价内容与方法

12.2.1 评价内容

1. 生理功能评价：活动受限（自理能力、躯体活动、体力活动等）、角色受限（工作、学习、家务等受限天数）
2. 心理功能评价：情绪反应（焦虑、抑郁等心理困扰）、认知功能（注意力、记忆力、思维清晰度）
3. 社会功能评价：社会交往的频率和质量、社会资源的利用
4. 总体健康评价：健康自评（Self-rated Health）——个体对自己健康状况的总体主观评价；生活满意度

12.2.2 评价方法（教学难点*）

针对特殊人群或特定疾病的生命质量评价量表，常常包括反映特殊人群特征或疾病症状等特异的内容。

！重点掌握：（教学难点*）生命质量评价的主要方法：

1. 量表评定法（最常用）：
 - 通过标准化问卷获取个体对各个维度主观感受的评分
 - 分为普适性量表（通用）和特异性量表（针对特定疾病或人群）
 - 普适性量表如 SF-36、WHOQOL、EQ-5D，适用于各类人群比较

生命质量评价的流程:

(一)选择或建立量表 (二)生命质量研究的设计与实施 (三)生命质量资料的统计分析

(一)选择或建立测量工具

1、选择量表(1)设计者的测量主题和测量目的(2)评价的层次 分维度，总体 (3)通用型量表与特异型量表，特异型:针对特定人群(如特定病患者) (4)量表的特性:信度、效度、反应度和可解释性。反应度:指量表检测生命质量随时间变化的能力和程度。可解释性:指解释量表分数意义的难易程度。 (5)内容的文化适应性本土化过程

2、建立新的量表(1)明确研究对象及目的(2)建立研究工作组(3)测定概念的定义及分解 (4)提出量表条目形成条目池 (5)确定条目的形式及回答选项-线性记分法-等级记分法(6)条目分析及筛选 -条目困难度-区分度-辨别力 -独立性 -代表性

方法:经典测量理论(条目标准差，相关系数，因子分析，克朗巴赫系数法) 条目反应理论(区分度、难度、条目信息量) (7)量表的量分方法 -直接累加 -加权累积(8)预试与修改(9)量表性能评价-信度 -效度 -反应度 -可解释性

(二)生命质量研究的设计与实施: 样本量，研究对象的依从性，研究对象的代理者- 一般情况下，生命质量不能由代理者评价- 特殊情况下，由代理者评价- 熟悉研究对象者，包括家庭成员、亲属、照料者、医生、护士等

(三)生命质量的统计分析1、生命质量资料的特点- 预处理- 多指标多终点的资料2、生命质量资料的评价目的- 区分:统一时点的横向分析 -评估:不同时点的纵向分析 -预测:生命质量与客观指标的结合分析3、生命质量分值的意义: 分值是一个没有单位的相对数字，它代表的意义要根据正常人群的分值分布状态来解释。影响因素:疾病，干预，老化，文化，其它

12.3 生命质量的测量工具

表 12.1: 常用生命质量测量工具

量表	开发者	特点
SF-36	美国 MOS (医学结局研究)	使用最广泛的普适性量表，36 条目 8 维度 (躯体功能、躯体角色、躯体疼痛、总体健康、活力、社会功能、情绪角色、心理健康)
WHOQOL-100/WHOQOL-BREF	WHO	跨文化适用性最强，BREF 版含 26 题 4 维度 (生理、心理、社会关系、环境)
EQ-5D	EuroQol Group	简洁的效用值量表，含 5 维度 (行动能力、自我照顾、日常活动、疼痛/不适、焦虑/抑郁) + VAS 自评，广泛用于药物经济学评价
疾病特异性量表	各领域开发	如 FACT (癌症)、AIMS (关节炎)、PDQ-39 (帕金森病) 等，对特定疾病的敏感度更高

12.4 生命质量评价的应用

一、人群健康状况的评定: 癌症病人、慢性退行性病人、老年人和康复病人的生命质量与健康测定，心血管系统疾病、晚期肾病、慢性阻塞性肺病、风湿病、乳腺癌、鼻咽癌、肺癌、胃癌、肠癌等。普通人群 比较 常模

二、卫生服务的效果评价与方案选择

三、卫生资源配置与利用的决策

(一)质量调整生存年(Quality adjusted life years,QALY)用生命质量来调整期望寿命或生存年数而得到的一个新指标，是生命质量和生命数量的有机统一。通过生命质量把不正常状态下的生存年数换成等同于健康人的生存年数。QALY的计算，首先用生命质量评价方法 得出各种功能状态的或不健康状态的效用值。将效用值作为权重(Wk)。再计 算各种功能状态下的生存年数(Yk)

(二)效果评价: 相同生存时间内的生命质量差异。

(三)成本-效用评价: 可以用QALY来表示效益。可用每获得一个QALY所需要的成本费用(即COST/QALY)来对各种方案或投资的经济效益作出分析。

13.1 社会卫生状况概述

[概念] 概念释义：社会卫生状况（Social Health Status）：一定时空范围内，人群的健康状况以及影响人群健康的各种社会因素的综合。

人群健康状况：人群的 衡量人群健康应该是 多维度的，包括躯体健康、心理和社会适应等多个方面。涉及影响人群健康的社会因素：死亡、疾病、残疾、生长发育等生理健康，也与心理状况、社会功能相联系。

- 社会经济发展水平

社会状况 经济状况 卫生体制 卫生政策 健康保障 卫生资源 卫生服务提供 卫生行为 健康公平

- 卫生服务系统（资源配置、可及性、质量）

13.1.1 社会卫生状况评价

1. **评价资料来源：** 人口普查数据； 生命登记系统（出生、死亡统计）； 疾病监测系统； 卫生服务常规报表； 专题调查（如国家卫生服务调查）； 国际组织数据库（WHO、UNICEF、世界银行等）

社会卫生状况评价的程序：确定社会卫生状况的内涵，把社会卫生状况的概念进一步具体化，形成若干范畴，根据所确定的范畴，寻找适宜的、有针对性的指标，根据所选定的指标，制定收集有关资料的计划，开展资料收集工作分析指标，归纳结果

社会卫生状况评价的意义• 找出主要的社会卫生问题，发现重点人群• 为制定社会卫生策略和措施、配置卫生资源提供依据• 评估社会卫生措施效果、卫生系统绩效的 工具

13.2.1 单一型指标

人群健康状况评价：是通过分析人群的健康水平及其变化，来探讨人群存在的健康问题，筛选影响人群健康的因素，评估各种健康计划、方案、措施的效果。

– 躯体指标：死亡、疾病、残疾、生长发育 – 心理状况指标– 社会功能指标

表 13.1: 常用单一型健康指标

指标类型	具体指标
死亡指标	死亡率、年龄别死亡率、婴儿死亡率（IMR）、5 岁以下儿童死亡率（U5MR）、孕产妇死亡率（MMR）、死因别死亡率
发病指标	发病率、患病率、疾病构成比
残疾指标	残疾发生率、残疾现患率
生长发育指标	低出生体重率、5 岁以下儿童低体重率、发育迟缓率
期望寿命	出生期望寿命（Life Expectancy at Birth）、健康期望寿命（HALE）

指某一人群 在一定时间内(通常是一年)，在目标生存年龄(通常定为70岁或出生期望寿命)内因死亡 而使寿命损失的总人年数。
减寿人年数是衡量某种死因对一定年龄范围内某人群危害程度的

13.2.2 复合型指标（教学难点*）

！重点掌握：（教学难点*）主要复合型健康指标：指标。将年龄不足70岁或平均期望寿命而死亡者称为“早死”。

1. **潜在寿命损失年（Potential Years of Life Lost, PYLL）：**

- 定义：某年龄组人群因某病死亡而损失的寿命年数
- 计算公式： $PYLL = \sum D_x \times (L - x)$ ，其中 D_x = 年龄 x 的死亡人数， L = 标准寿命上限（通常为 70 岁）， x = 死亡年龄的中点
- 意义：强调“早死”对寿命的损失，给予年轻死亡更高的权重
- 应用：确定优先干预的疾病和健康问题

特点：PYLL是研究某死因对人群健康影响较好的一种方法，其不受年龄构成的影响，能反映个别死因对全人口的作用，并且PYLL往往反映死亡对寿命影响的实际水平，另外该指标容易 计算具有可加性。

以残疾作为观察终点。

基本原理:用现时期望寿命表,减去某些伤残状态或健康低下的生存年数,并重新计算新的期望寿命。

LEFD是质量较高的生命过程,能更好的反映一个国家、一个地区社会、经济发展和任命生活质量的综合水平。

2. 无残疾期望寿命 (Disability-Free Life Expectancy, DFLE/LEFD):

- 以无残疾状态下的期望寿命来评价人群健康水平
 - 扣除了因残疾而损失的寿命年
- 以日常生活自理能力的丧失作为观察终点,代替普通寿命表中的死亡。它指的是人们能维持良好的日常生活活动功能的年限。

3. 活动期望寿命 (Active Life Expectancy, ALE):

- 日常生活中能保持自理能力、无依赖的期望寿命年限
- 对老年人群的健康评价尤为重要

4. 伤残调整寿命年 (Disability Adjusted Life Year, DALY): 衡量健康生命损失情况的单位, 用年数表示。

- 目前最广泛使用的疾病负担综合评价指标
 - $DALY = YLLs$ (早死生命损失年) + $YLDs$ (伤残生命损失年)
 - 综合考虑了早死和失能两种健康损失
 - 用于疾病负担 (Global Burden of Disease, GBD) 研究
 - 意义: 一个 DALY 代表因早死或伤残而损失的一年“完全健康”生命
 - 可比较不同疾病、不同地区、不同时期的疾病负担
 - DALY 的局限性:** 年龄权重和贴现率的选择有争议; 残疾权重的主观性; 未考虑共存疾病的影响; 数据不足影响低收入国家的精确性; 未包括社会环境因素对疾病负担的影响
- 目前全球疾病负担均以DALY 为单位进行测算。

5. 健康期望寿命 (Healthy Life Expectancy, HALE):

- 以“完全健康状态”的期望寿命来衡量人群健康水平
- WHO 自 2000 年起定期发布各成员国的 HALE 数据

13.3 健康影响因素指标

2、自然环境指标

☐年空气污染天数比例 ☐公共场所卫生监督率 ☐有毒有害作业点年监测覆盖率 ☐自来水入户比例 ☐二次供水点监测合格率 ☐垃圾管理合格率 ☐卫生厕所普及率 ☐每万人拥有公共厕所数 ☐人均居住面积 ☐人均占有公共绿地面积 ☐安全饮用水普及率

13.3.1 人口学指标

- 人口数量:** 总人口数、人口密度
- 人口分布:** 城乡分布、地区分布
- 性别构成:** 性别比 (正常 103-107)
- 年龄构成:** 各年龄组占比、老龄化程度 (65 岁及以上 $\geq 7\%$ 为老龄化)、抚养系数
- 人口自然增长:** 出生率-死亡率 = 自然增长率

13.3.2 社会发展指标 (教学难点 *)

! 重点掌握: (教学难点 *) 主要社会发展指标:

1. 人类发展指数 (Human Development Index, HDI):

- UNDP 于 1990 年提出, 综合反映社会经济发展水平
- 三个维度: 健康长寿 (预期寿命指数)、教育获得 (教育指数)、生活水平 (收入指数, 按购买力平价调整的人均 GDP)
- $HDI =$ 三个维度指数的几何平均数
- 分级: ≥ 0.800 为极高人类发展水平

2. ASHA 指数 (American Social Health Association Index):

- 由美国社会健康协会提出
- 计算公式: $ASHA = (\text{就业率} \times \text{识字率} \times \text{平均期望寿命} \times \text{人均 GDP 增长率}) / (\text{出生率} \times \text{婴儿死亡率})$
- 综合反映社会经济发展和健康水平

3. 物质生活质量指数 (Physical Quality of Life Index, PQLI):

- 由婴儿死亡率、1 岁期望寿命和识字率三项指标组成
 - 三项指标各赋 0-100 分, 求算术平均值
 - 值越高表明生活质量越好
 - 优势: 简单、易于计算、不受 GDP 影响
- SSPS以社会、经济、生态为基点, 以人的生命 周期为主线, 将人们从出生到死亡的整个 生命过程的主要活动联系起来, 通过对生 命周期各阶段具体情况的描述和分 析来评 价整个社会发展水平的变化趋势。

4. 社会进步指数 (Social Progress Index, SPI):

- 衡量社会在满足人类基本需求、建立福祉基础和创造机会三个方面表现的综合性指标

单一指标:

☐15岁以上人口识字率 ☐人均国内生产总值 ☐人均国民收入 ☐劳动力人口就业率 ☐恩

格尔系数: 食物支出金额占消费总支出的比例。

一个国家或家庭生活越贫困, 恩格尔系数就越大;反之, 生活越富裕, 恩格尔系数就越

小。

13.3.3 健康公平指标

[概念] 概念释义：健康公平（Health Equity）：不同社会群体之间不存在可避免的、不公平的健康差异。健康公平关注的是**健康差异的社会根源和可改变性**。

主要衡量指标：

- **基尼系数（Gini Coefficient）**：取值范围 0-1，衡量健康或卫生服务在人群中的不平等程度。0= 完全平等，1= 完全不平等
- **集中指数（Concentration Index）**：衡量与经济社会地位相关的健康不平等程度。正值表示健康集中在富人群体，负值表示集中在穷人群体
- **比率和差值**：不同阶层或地区健康指标之比和之差，直观反映差异大小

13.4 中国与全球社会卫生状况

13.4.1 中国社会卫生状况

！重点掌握：健康中国（Healthy China）——中国卫生事业发展战略：

1. 《“健康中国 2030”规划纲要》（2016 年）——将健康纳入国家发展战略的核心，提出“以人民健康为中心”的发展理念
2. **五大战略任务**：普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业
3. **核心目标**：2030 年人均期望寿命达到 79 岁（2020 年 77.3 岁），婴儿死亡率降至 5.0‰ 以下，孕产妇死亡率降至 12/10 万以下
4. **主要成就**：人均期望寿命从 1949 年的 35 岁升至 2020 年的 77.3 岁；孕产妇死亡率从 1500/10 万降至 16.9/10 万；婴儿死亡率从 200‰ 降至 5.4‰

13.4.2 全球健康状况与全球卫生

- 全球健康面临的核心挑战：传染病（艾滋病、结核病、疟疾）+ 慢性非传染性疾病（NCDs 占全球死亡 71%）+ 新发传染病 + 健康不公平
- 全球卫生：超越国界的、需要全球共同行动来解决的健康问题和挑战

13.5 全球卫生策略

13.5.1 21 世纪人人享有卫生保健

！重点掌握：WHO“21 世纪人人享有卫生保健”（HFA 21 世纪）：

主要内容：

1. 实现健康公平——缩小国家间和国家内部的健康差距
2. 强调生命全程健康——从围生期到老年的全程保障
3. 预防为主——重视非传染性疾病和精神卫生的预防
4. 改善卫生系统绩效——提高质量、效率、反应性和公平性

总目标（至 2020 年）：

1. 增加全体人民的期望寿命和生活质量
2. 改进国家间和国家内部的健康公平
3. 使全体人民能利用可持续的卫生系统服务

13.5.2 初级卫生保健（PHC）

[概念] 概念释义：初级卫生保健（Primary Health Care, PHC）：**1978 年 Alma-Ata 宣言**正式提出，是基本的卫生保健服务，是社区中个人和家庭能够普遍获得的基本卫生服务，是卫生系统的最前沿和第一级接触点，也是实现“人人享有卫生保健”目标的关键途径。

！重点掌握：初级卫生保健的基本原则：

1. **社会公平**——卫生服务应公平可及，特别关注弱势群体

观察终点,代替普通寿命表中的死亡。是人们能维持良好日常生活活动功能年限。

④**伤残调整生命年 (disability adjusted life year, DALY)**: 最常用,用**生命质量**来调整**期望寿命或生存年数**得到的一个新指标,是生命质量和生命数量的有机统一。通过生命质量把不正常状态下的生存年数换算成等同于健康人的生存年数。

⑤**健康期望寿命 (healthy life expectancy, HALE)**: 扣除了死亡和伤残影响后的平均期望寿命,可理解为“完全健康期望寿命”。

2.健康影响因素指标

(1) 人口学指标: 人口数量、人口分布、年龄比例、性别比例、人口增长率。

(2) 社会发展指标

①**人类发展指数 (HDI)**: 联合国开发计划署用以衡量各国社会经济发展程度的标准,并依此区分已开发(高度开发)、开发中(中度开发)、低度开发国家,也用来衡量经济政策对生活质量的影响。涵盖经济收入、健康和教育3个方面,收入用实际人均国内生产总值(购买力平价美元)衡量,平均期望寿命用出生时期望寿命衡量,教育程度用成人识字率(2/3 权重)及小学、中学、大学综合入学率(1/3 权重)共同衡量。

$$HDI=(\text{平均期望寿命指数} \times \text{教育指数} \times \text{收入指数})^{1/3}$$

②**美国社会健康协会指标 (American social health association, ASHA)**: 衡量社会发展的综合指标,包括就业率、识字率、平均期望寿命、人均国民生产总值增长率、出生率和婴儿死亡率等。

$$ASHA=(\text{成人识字率} \times \text{就业率} \times \text{人均国民生产总值增长率} \times \text{平均期望寿命}) / (\text{出生率} \times \text{婴儿死亡率})$$

③**物质生活质量指数 (Physical quality of life index, PQLI)**: 衡量一个国家或地区居民的营养、卫生保健和教育水平的综合指标,强调了卫生与教育质量在社会经济发展中的作用,弥补了仅用国内生产总值指标的不足。PQLI>80 为高素质人口,<60 为低素质人口。

$$PQLI=(\text{婴儿死亡率指数} + 1 \text{ 岁期望寿命指数} + \text{识字率指数}) / 3$$

④**社会和人口学统计指标体系 (SSPS)**: 以社会、经济、生态为基点,以人的生命周期为主线,将人们从出生到死亡整个生命过程主要活动联系起来,通过对生命周期各阶段具体情况的描述和分析,评价整个社会发展水平的变化趋势。

⑤**国民幸福指数 (national happiness index, NHI)**: 综合衡量一个国家或地区生态环境、政府管理、经济发展、社会进步、居民生活与幸福水平的指标。

(3) 卫生服务指标(第十章);(4) 卫生资源指标(第十章);(5) 卫生政策与保障指标;(6) 健康行为指标(第七章);(7) 健康公平指标: 基尼系数法、集中指数法、人群归因危险度法、健康差异指数法、极差法与率比法。

第二节 健康中国(《“健康中国 2030”规划纲要》)

一、**战略目标**: 提出健康中国 2020 年、2030 年、2050 年“**三步走**”的目标。

1.**2020 年**: 主要健康指标居于**中高收入**国家前列。

2.**2030 年**: 主要健康指标居于**高收入**国家前列。

3.**2050 年**: 建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。

二、基本原则

1. **健康优先**：把健康放在优先发展的战略地位。
2. **改革创新**：形成有中国特色、促进全民健康的制度体系。
3. **科学发展**：坚持新形势下卫生与健康工作方针，构建整合型医疗卫生服务体系。
4. **公平公正**：实现全民健康覆盖，促进社会公平。

三、**战略主题**：“**共建共享（基本路径）、全民健康（根本目的）**”。

四、**战略任务**：1.普及健康生活；2.优化健康服务；3.完善健康保障；4.建设健康环境；5.发展健康产业。

第三节 全球卫生策略

一、21 世纪人人享有卫生保健

1.主要内容

（1）重申健康是每个公民的一项基本人权，每个公民都有相同的权利、义务和责任获得最大可能的健康。

（2）人类的健康水平提高和幸福，是社会经济发展的终极目标。

2. **政策基础**：（1）健康是人类发展的中心；（2）卫生系统的可持续发展。

3.总体目标

（1）提高平均期望寿命的同时提高生活质量。

（2）在国家内部和国家间改善健康的公平程度。

（3）卫生系统可持续发展，保证人民利用这一系统提供的服务。

4. **实施策略**：（1）与贫困做斗争；（2）在所有环境中促进健康；（3）部门间的协调、协商和互利；（4）将卫生列入可持续发展规划。

二、**初级卫生保健（primary health care, PHC）/基本卫生保健**：普及适宜的、技术可靠、社会能接受和负担的技术，使全体人民公平地获得基本卫生服务。

1.内涵

（1）服务对象：全体居民，使卫生保健服务最大限度深入到人们工作和生活的场所。

（2）服务方法：经过实践检验、有科学依据，且其费用能为个人和政府负担。

（3）工作重点：预防疾病，增进健康，控制和消灭一切危害人民健康的因素。

（4）目的：使全体人民公平获得基本卫生保健服务，促使全体社会成员达到与社会经济发展水平适应的最高可能的健康水平。

（5）初级卫生保健不代表低水平、低成本和简单，而强调公平合理地分配和利用卫生资源，注重成本投入的效率和效果。

2. **基本原则**：（1）**社会公平原则**：合理布局；（2）**参与原则**：社区参与；（3）**部门协同原则**：综合途径；（4）**成本效果和效率原则**：预防为主，适宜技术。

3. **基本任务**：**促进健康、预防、治疗、康复**。

4. **基本要素**：（1）增进必要的营养和供应充足的安全水；（2）基本的环境卫生；（3）妇幼保健（包括计划生育）；（4）主要传染病的预防接种；（5）地方病的预防和控制；（6）当前主要卫生问题及其预防控制方法的宣传教育；（7）常见病和创伤的恰当处理；（8）保证基本药物供应。

2. **社区参与**——社区和个人应参与卫生服务的规划和组织
3. **成本效益**——采用技术上适宜、经济上可承担的方法和技术
4. **部门协作**——卫生部门之外的农业、教育、住房、公共工程等部门均应参与
5. **预防为主**——关注健康促进和疾病预防，而非仅仅是治疗

初级卫生保健的基本要素（8项）：

1. 健康教育——普及健康知识
2. 合理营养与食品安全——促进适当的食物供应和营养
3. 安全饮水和基本环境卫生——足够的安全用水和基本卫生设施
4. 妇幼保健与计划生育——包括围产期保健
5. 计划免疫——主要传染病的免疫接种
6. 地方病的预防和控制
7. 常见病和伤害的适当治疗
8. 基本药物的提供

13.5.3 千年发展目标与可持续发展目标

[提示] 要点提示：可持续发展目标（SDGs）中与健康相关的目标：

SDG 3 的具体目标包括——降低全球孕产妇死亡率（ $<70/10$ 万）；消除新生儿和 5 岁以下儿童可预防的死亡；终结艾滋病、结核病、疟疾等传染病流行；将 NCDs 过早死亡减少 1/3；实现全民健康覆盖（UHC）；确保普遍获得性与生殖健康服务。

13.6 复习题

一、选择题

1. DALY 等于：
 - (A) $YLLs - YLDs$
 - (B) $YLLs + YLDs$
 - (C) $YLLs \times YLDs$
 - (D) $YLLs \div YLDs$
2. PQLI 由哪三项指标构成？
 - (A) 婴儿死亡率、1 岁期望寿命、识字率
 - (B) 婴儿死亡率、成人死亡率、GDP
 - (C) 识字率、GDP、期望寿命
 - (D) GDP、IMR、MMR
3. 初级卫生保健（PHC）是哪次会议正式提出的？
 - (A) 1948 年 WHO 宪章
 - (B) 1978 年 Alma-Ata 宣言
 - (C) 2000 年联合国千年首脑会议
 - (D) 2015 年联合国可持续发展峰会
4. 中国政府提出的“健康中国 2030”核心目标中，2030 年人均期望寿命目标为：
 - (A) 75 岁
 - (B) 77 岁
 - (C) 79 岁
 - (D) 82 岁
5. SDGs 中含多少项目标？
 - (A) 8 项
 - (B) 12 项
 - (C) 17 项
 - (D) 21 项

二、名词解释

1. 伤残调整寿命年（DALY）
2. 潜在寿命损失年（PYLL）

一、健康观的演变

传统健康观 → 整体健康观

“无病就是健康”是传统健康(classical health)观的核心。

WHO指出:“健康不仅仅是没有疾病和虚弱现象,而且是一种躯体上、心理上和社会适应方面的完好状态”

健康社会决定因素模型

达尔格林(Dahlgren)和惠特海德(Whitehead)在1991年建立了健康社会决定因素的分层模型。该模型由内向外分别代表影响人类健康的主要因素(微观、中观、宏观)。

三、健康管理系统的构建与发展

16.1 健康管理概述

16.1.1 健康管理产生的背景

1. **疾病谱和医学模式的转变**——慢性非传染性疾病成为主要疾病负担,要求从“治疗已病”转向“管理健康”
2. **医疗费用持续增长**——人口老龄化、新技术应用等推动医疗费用不断攀升,需要“以管理促节约”
3. **健康管理理念的兴起**——20世纪20-30年代美国最早出现健康管理萌芽(1929年Kaiser健康计划),60-70年代HMO(健康维护组织)的发展为健康管理提供了组织模式
4. **循证医学和信息技术的发展**——为健康管理的科学化和信息化提供了支撑

16.1.2 健康管理的演变

- ❑ 健康管理活动最早起源于美国、加拿大等西方国家开展的临床预防服务。
- ❑ 新兴行业 最近20-30年作为一门学科及行业在西方兴起并日趋完善
- ❑ 市场需要是健康管理行业兴起的基础 - 人的寿命延长- 慢性疾病患病率增加- 医疗费用大幅度持续上升
- ❑ 很快地向规范性及普及性方面发展 - 多种类型的服务方式:- 广泛的应用:- 系统的研究与评价机制:- 以公司面貌出现

16.1.3 健康管理的概念和内涵

健康管理是指以人们的健康需要为导向,通过对个体和群体健康状况以及各种健康危险因素的全面监测、分析、评估及预测,向人们提供有针对性的健康咨询和指导服务,通过制订健康管理计划,协调个人、组织和社会行动,对各种健康危险因素进行系统干预和管理。宗旨是更好地调动和整合个人、集体和社会的健康管理资源和行动,通过有效的计划、组织、协调和控制等管理活动来获取最大的健康效果。

3. 以预防为导向——防患于未然,关注全生命周期
4. 强调个体主动性——调动个人积极性,自我管理健康
5. 持续动态管理——健康管理是持久、连续的过程

16.1.4 现代健康管理的新特点

- ❑ 健康管理呈现多层次化,形成了多水平的健康管理系统
- ❑ 健康管理的内容、对象和范围不断扩展
- ❑ 健康管理手段日趋多样化
- ❑ 强调横向与纵向健康管理和协调机制的建立

16.2 健康管理的基本内容与步骤

第一步:收集信息(了解你的健康)

收集服务对象的个人健康信息,包括个人一般情况(性别、年龄等)、目前健康状况和疾病家族史、生活方式(膳食、体力活动、吸烟、饮酒等)、体格检查(身高、体重、血压等)和血、尿实验室检查(血脂、血糖等)。

第二步:健康风险评估

- ❑ 即根据所收集的个人信息,对个人的健康状况及未来患病或死亡的危险性用数学模型进行量化评估。
- ❑ 其主要目的是帮助个体综合认识健康风险,鼓励和帮助人们纠正不健康的行为和习惯,制订个性化的健康干预措施;此外,也有利于评价干预措施有效性,以及对人群分类并筛选高危人群等。
- ❑ 健康风险评估是一个广义的概念,它包括了简单的个体健康风险分级以及复杂的群体健康风险评估模型。

第三步:实施健康干预

❑ 以多种形式来帮助个人采取行动、纠正不良的生活方式和习惯，控制健康危险因素，实现个人健康管理计划的目标。

❑ 与一般健康教育和健康促进不同的是，健康管理过程中健康干预是个性化的，即根据个体的健康危险因素，由健康管理师进行个体指导，设定个体目标，并动态追踪效果。如健康体重管理、糖尿病管理等，通过个人健康管理日记、专项健康维护课程及跟踪随访措施来达到健康改善效果。

❑ 提供健康投资信息及转介服务。

第四步:进行干预效果评估

❑ 及时对健康干预的实施效果进行动态追踪，了解存在的问题，评价计划和措施的实施效果，并对干预方案做进一步的完善。

16.2.2 健康管理策略（教学难点*）

！重点掌握：（教学难点*）健康管理的六大基本策略：

1. **生活方式管理（Lifestyle Management）**——通过健康教育和行为干预，帮助人们采纳和维持健康的生活方式。核心手段：健康教育、激励机制、行为矫正。目标：减少健康危险行为（吸烟、酗酒、不良饮食、缺乏运动等）
2. **需求管理（Demand Management）**——运用远程医疗、健康咨询、自我管理支持等手段，帮助人们更好地利用卫生服务，避免不必要和不恰当的卫生服务使用。主要工具：24小时电话健康咨询、在线健康信息、分诊系统
3. **疾病管理（Disease Management）**——以特定疾病患者为对象，采用系统化、协调化的服务模式，改善疾病结局。强调：循证医学指导、患者自我管理、多学科团队协作、持续质量改进。典型对象：糖尿病、高血压、哮喘、COPD等慢性病
4. **灾难性伤病管理（Catastrophic Case Management）**——针对严重伤病或高额医疗费用病例的专门管理，通过个案管理和专业评估，在确保医疗质量的同时控制费用。要求：专业的个案管理师、综合评估和资源配置
5. **残疾管理（Disability Management）**——减少工作场所残疾发生，促进因伤病缺勤者尽早康复和重返工作。关注：早期康复介入、工作环境调整、心理支持和职业康复
6. **综合人群健康管理（Population Health Management）**——整合以上多种策略，对整个人群的健康进行系统化综合管理，强调：数据驱动的风险评估和分层管理、多策略的协调实施、跨部门协作、健康结果和成本效益评估

16.3 健康治理

[概念] 概念释义：健康治理（Health Governance）：政府、市场、社会组织、公民等**多元主体**通过协商、合作和共同行动，共同应对健康问题和挑战的持续过程。

健康治理的特点：

1. **多元主体参与**——不仅限于政府，还包括企业、社会组织、社区、公民等
2. **协商共治**——各主体间通过协商而非命令来达成共识
3. **透明和问责**——决策过程透明、各主体有明确责任并接受监督
4. **网络化治理**——治理结构从“垂直层级”转向“网络协作”
5. **全球视野**——健康问题超越国界，需要全球治理机制

16.3.1 健康管理与健康治理的联系与区别

！重点掌握：联系：

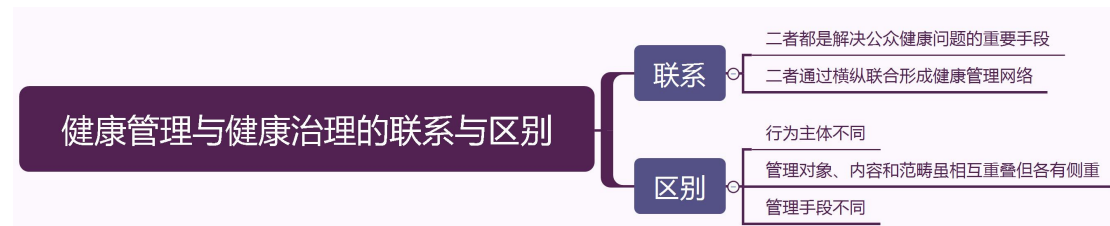
- 健康治理是健康管理理念的延伸和升级
- 两者都强调以健康为中心、预防为主
- 健康治理为健康管理提供了更广泛的制度框架和组织支撑

区别：表 16-1 健康管理与健康治理的比较

2.健康治理（health governance）：政府不同部门、卫生服务提供者、企业与社会组织、医疗服务使用者、公众等众多利益主体，为保障其健康共识和一致性行动目标的达成，而制定的一系列正式和非正式制度和规则安排，以推动协调一致的健康政策、策略落实以及公共健康问题解决的联合行动过程。

3.健康治理的特点：（1）治理主体多元化；（2）治理机制多样化；（3）治理策略创新；（4）治理手段多样化。

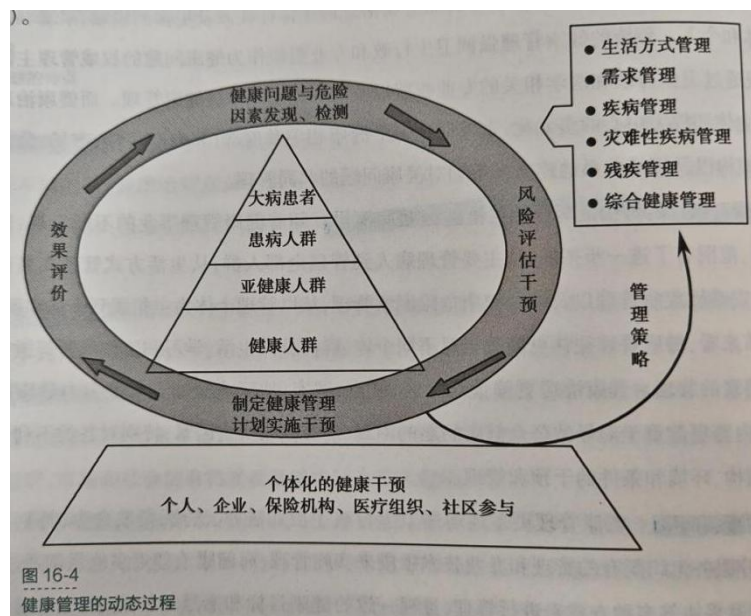
三、健康管理与健康治理的联系与区别



第三节 多层次健康管理 with 治理

一、个体与群体健康管理

1.个体与群体健康管理的核心内容：以服务为载体，以管理为手段，通过有计划有组织的系统活动来对个体和群体中的健康问题和健康危险因素进行检测、评价和干预，健康管理是由健康危险因素检测-评价-干预-再评价等核心环节要素组成的一个动态循环过程。



2.健康管理的基本步骤：（1）收集健康管理对象的个人健康信息；（2）进行健康和疾病风险评估与预测、疾病预警；（3）实施健康干预；（4）进行干预效果评价。

3.健康管理策略

（1）生活方式管理

①对人们的不良行为和生活方式进行干预，通过健康教育和健康促进培养人们的健康习惯，远离不良习惯，建立健康的行为和生活方式，最大限度降低健康风险

暴露水平。

②特点：A.以个体为中心，强调个体对自身健康的责任和作用；B.以预防为主，有效整合三级预防；C.通常与其他健康管理策略联合进行。

③干预技术：教育、激励、训练、市场营销。

（2）需求管理

①通过帮助病人进行健康维护以及寻求适当的医疗保健，来控制健康消费的支出和改善病人对医疗保健服务的利用。通过为人们提供各种可能的信息和决策支持、行为支持以及其他方面的支持，来帮助其在正确的时间、正确的地点，寻求恰当的卫生服务。

②实现途径

A. 对需方的管理：通过对人们卫生保健需求实施影响和指导，帮助其做出理性消费选择。

B. 对供方的管理：管理性保健（家庭医生签约服务）。

（3）疾病管理

①一个协调医疗保健干预和与病人沟通的系统，强调病人自我保健的重要性。疾病管理支撑改善医患关系和完善保健服务计划，强调运用循证医学和增强个人能力的策略预防疾病恶化，以持续性改善个体或全体健康为基准，从临床、人文和经济等方面对整体健康状况的改善进行动态评价。

②内容：目标人群筛选，循证医学指导，协调医疗服务与其他辅助服务，病人自我管理教育，关注对疾病管理过程和结果的测量、评价和管理，定期报告反馈。

③特点

A. 目标人群是患特定疾病的个体。

B. 不是一次性治疗活动，不以单个病例、单次就诊时间为中心；而是关注个体或群体健康状况和生命质量的连续性过程。

C. 医疗卫生服务和干预措施的综合协调至关重要。

（4）灾难性疾病管理

①灾难性疾病：对健康危害十分严重，或会导致巨额治疗费用的一类疾病，如癌症、肾衰等。

②灾难性疾病管理是疾病管理的一个特殊形式。

③良好灾难性疾病管理的特点：A.转诊及时；B.综合考虑各方面因素，制定适宜医疗服务计划；C.拥有一支包含多种医学专科及综合业务能力的服务队伍，能有效应对可能出现的多种医疗服务需要；D.最大程度帮助患者进行自我管理；E.患者及其家属满意。

（5）残疾管理

①残疾管理是针对因工作导致的伤残人士进行评估及体能和心理恢复的过程，其目的是促进因工残疾人员的身心康复，提高生活质量，尽早返回工作岗位，减少费用代价。

②从雇主角度出发，根据伤残程度分别处理，尽量减少因残疾造成的劳动和生活能力下降。

③内容：预防伤残发生，防止残疾恶化，注重残疾人功能性能力恢复而不仅是病人疼痛缓解，制定衡量实际康复和返工的标准，详细说明残疾人今后行动的限制事项和行事项，评估医学和社会心理学因素对残疾人的影响，帮助残疾人和雇主进行有效的沟通，帮助伤残者尽早恢复，重返工作岗位，实现循环管理。

（6）综合人群健康管理

- ①通过协调以上 5 种健康管理策略对人群中的个体提供更全面的健康管理。
- ②健康管理实践中基本都考虑采取综合人群健康管理模式。

二、社区管理与治理

1. **社区管理**：以改善社区居民健康为目标，通过对社区居民健康需要、问题及影响因素的分析，实施社区健康诊断，查明社区主要健康问题及其产生根源和机制，制订优先干预清单和社区健康管理干预计划，通过健康教育、膳食指导、运动锻炼、不良环境改造等综合社区卫生服务和健康管理活动的开展，实现提升社区居民整体健康水平的目标。
2. **社区治理**：针对社区主要健康问题和挑战，通过多种途径和方式，推动跨部门协作、促进社区伙伴及社区合作网络建立，通过对社区不良环境和条件、健康危险因素及重点健康问题协调一致的干预行动，推动社区健康管理目标的实现。

第十三章 生命质量评价

第一节 生命质量评价概述

一、生命质量（quality of life, QOL）

1. WHO：不同文化和价值体系中的个体对与他们的生活目标、期望、标准及关心事情有关的生活状态的体验。
2. 以社会经济、文化背景和价值取向为基础，人们对自己身体状态、心理功能、社会能力及个人综合状况的感觉体验，反映了个人期望与实际生活状况间的差距，差距越大，生命质量越差。特点：
 - （1）是一个多维概念，包括生理、心理、社会全面功能。
 - （2）测量健康的正向和负向方面。
 - （3）主观评价指标，应由被测者自评，多采用功能或行为术语说明。
 - （4）动态性，即 QOL 随时间推移发生改变。
 - （5）有文化依赖，须建立在一定文化体系下。

二、生命质量与生命数量的关系

1. 生命质量与生命数量相互联系、相互制约，是人类生存的两个方面。
2. 生命数量是生命质量的基础，只有具备一定生命数量，才可能谈及生命质量。
3. 生命数量和生命质量有时出现对立，人们可能不得不牺牲一定生命数量来换取更好的生命质量，反之亦然。

三、生命质量与健康的关系

1. 广义上，生命质量评价的就是健康。健康是生命质量的重要构成部分、核心和主要决定因素。
2. **健康相关生命质量（health-related quality of life, HRQOL）**：在疾病、意外损伤、医疗干预、老化和社会环境改变影响下人们的健康状态及与其经济、文化背景和价值取向联系的主观体验。

四、生命质量的构成

比较维度	健康管理	健康治理
主体	以卫生专业人员和管理者为主	多元主体（政府、市场、社会、公民）
方式	以专业手段进行管理和干预	以协商、合作、共同行动实现
对象	个体或群体的健康风险	健康的社会决定因素和系统问题
范围	侧重卫生服务领域	跨部门、跨领域的社会性治理
机制	计划、组织、协调、控制	参与、协商、透明、问责

16.4 不同层次的健康管理与治理

一、个体与群体的健康管理

(一)个体、群体健康管理的核心内容

是通过有计划有组织的系统活动对个体和群体中的健康问题和健康危险因素进行检测—评价—干预—再评价等。
一个动态循环过程。

二、以社区为基础的健康管理与治理 (一)社区健康管理

社区健康管理是以改善社区居民健康为目标，通过对社区居民健康需要、问题及影响因素的分析，实施社区健康诊断，查明社区主要健康问题及其产生根源和机制，制订优先干预清单和社区健康管理干预计划，通过健康教育、膳食指导、运动锻炼、不良环境改造等综合社区卫生服务和健康管理活动的开展，实现提升社区居民整体健康水平的目标。

社区健康治理是指针对社区主要健康问题和挑战，通过多种途径和方式，推动跨部门协作、促进社区伙伴以及社区合作网络的建立，通过对社区不良环境和条件、健康危险因素以及重点健康问题的协调一致的干预行动，推动社区健康管理目标的实现。

(二)新型社区健康管理

与治理模式的探索及组织策略选择

社区健康治理的关键环节

三、卫生系统健康管理

四、国家健康管理

五、全球健康治理

- 基本概念:全球健康治理是指全球多元主体通过多样化的途径共同参与全球健康相关问题的综合治理的过程。
- 基本功能:形成价值共识、领导和协调功能、制定规则/协调和规范行为、动员和分配资金、实现多元治理。

三、简答题

1. 简述健康管理的六大基本策略。
2. 简述健康管理的基本步骤。
3. 试述健康管理与健康治理的联系与区别。

地域型社区是以地理范围为基础的，由不同的个体或家庭生活在此彼此相邻的空间，而形成共享公共资源及相互依存的关系。

功能型社区是不同个体因某种共同特征，如共同兴趣、利益、职业或价值观等形成相互联系的机构或组织。即由有相同的认同感与归属感和文化特色(价值观念、行为规范、交流与互助方式等)的居民组成。

两者关系:一个或几个功能型社区可以嵌套在一个地域型社区内。

17.1 社区与社区卫生服务概述

17.1.1 社区的定义、类型与要素

社区是以某种经济的、文化的、种族的社会凝聚力，使人们生活在一起的一种社会组织或团体。(1978年)

核心:某一地域里的人们具有某种内在的联系。地域、血缘、政治、经济、社会、文化等社区的概念因研究的角度、着重点、理论背景、解决的问题等而各不相同。

社区的要素与类型

构成社区的五大要素:

1. 一定数量的人群——社区的主体

2. 一定的地域范围——社区的空间载体

3. 共同的文化和生活方式——社区的纽带

4. 共同的利益和认同感——社区的凝聚力

5. 一定的社会组织和服务体系——社区的运作机制

地域，人口，归属感与社会认同，管理机构与制度，精神文化氛围背景，服务设施

社区类型:

• 按人口分布: 城市社区、农村社区、城乡结合部社区

• 按功能特征: 居住型社区、工作型社区、混合型社区

• 按形成方式: 自然形成社区、规划设置社区(如街道办事处辖区、居委会辖区)

17.1.2 社区卫生服务的概念与对象

[概念] 概念释义: 社区卫生服务 (Community Health Service, CHS): 在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下, 以**基层卫生机构为主体**, 全科医师为骨干, 合理使用社区资源和适宜技术, 以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向, 以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为重点服务对象, 以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的, 融**预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务**等于一体的有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

! 重点掌握: 社区卫生服务的对象:

社区、社区居民及其家庭, 包括辖区内的常住居民、暂住居民及其他有关人员, 具体包括:

1、健康人群 2、高危人群 3、重点保健人群 4、病人

5. **患者**——常见病、多发病的诊治和慢性病管理

17.1.3 全科医学

全科医学(general practice)是指导全科医生从事基层医疗保健第一线服务的知识技能体系, 其重点是根据学科发展需要和不同地域中人群的健康需求, 研究解决社区居民常见健康问题所需要的知识、技能、态度及医疗服务管理的方法等。属于临床二级学科。全科医疗服务是社区卫生服务的主要医疗形式。

全科医生(general practitioner, GP)

是社区卫生服务的核心。

2.全科医学（general practice）：属于临床二级学科。指导全科医生从事基层医疗保健第一线服务的知识技能体系，重点是根据学科发展需要和不同地域中人群的健康需求，研究解决社区居民常见健康问题所需要的知识、技能、态度及医疗服务管理的方法等。全科医疗服务是社区卫生服务的主要医疗形式。

第二节 社区卫生服务的特点与内容

一、社区卫生服务的特点：公共卫生群体服务特征+个体化医疗服务特点

1.以健康为中心：治疗疾病+预防疾病+促进健康。

2.以需求为导向：服务内容和形式应适合当地居民卫生需求，并充分利用社区资源，为社区居民提供基本卫生服务。

3.以家庭为单位

（1）家庭是社区组成的最基本单元，也是社区卫生工作的重要场所和可利用的有效资源。

（2）家庭的结构和功能会直接或间接影响家庭成员的健康。

（3）及时发现家庭生活周期的不同阶段出现或存在的压力事件。

4.以预防为主：生命周期保健+个体化预防服务。

5.人性化服务：全科医生须把服务对象视为合作伙伴，全面考虑其生理、心理、社会需求并加以解决；以人性化的服务调动病人的依从性和主动性。

6.综合性服务：综合、全方位、多部门参与。服务对象（病人、非病人）、服务内容（预防、治疗、康复）、服务层面、服务范围（个人、家庭和社区）、服务方式。

7.连续性服务

（1）生命周期各个阶段：围产期、分娩、婴幼儿生长发育、儿童青少年保健、中老年慢性病管理、濒死病人临终关怀。

（2）健康疾病周期各个阶段：一级、二级、三级预防、诊疗、康复服务，健康促进、危险因素监控，疾病早、中、晚期管理。

（3）任何时间地点，提供力所能及、适当的服务。

8.协调性与团队合作式服务：为提供一体化、全方位、全过程的医疗卫生服务，社区卫生服务提供者成为社区居民个体和群体的健康资源协调人，成为动员各级、各类健康相关资源服务于个体及其家庭的枢纽。

9.可及性服务：地理上的接近、操作上的方便、关系上的密切、心理上的信任、结果上的有效、经济上的可接受。

10.首诊医疗服务

（1）社区卫生服务是第一线卫生服务，是居民最先接触、最常利用的基层医疗保健服务。

（2）社区卫生服务机构是首诊机构，全科医生是首诊医生。

二、社区卫生服务的内容

1.基本公共卫生服务：向全体居民提供公益性的公共卫生干预措施，起到对疾病的预防与控制作用。

2.基本医疗服务：对全体居民提供最基本的福利性医疗照顾，即采用基本药物、使用适宜技术，按规范诊疗程序提供急慢性疾病诊断、治疗和康复等医疗服务。

三、社区卫生服务的意义

- 1.提供基本卫生服务，满足人民群众日益增长的卫生服务需求，提高人民健康水平的重要保障。
- 2.解决疾病和死亡谱变化带来的问题，积极应对人口老龄化挑战的重要途径。
- 3.深化城市医疗卫生体制改革，建立新型城市卫生服务体系的重要基础。
- 4.提高卫生服务公平，维护社会稳定的重要途径。

第三节 社区卫生服务模式

一、社区卫生服务的管理

1.社区卫生服务的筹资机制

- (1) 政府主导，多元化筹资渠道并存。
- (2) 社区公共卫生服务由政府采取购买服务；社区基本医疗服务一般由社区医疗保险和个人付费，由服务收费补偿。
- (3) 实行收支两条线管理。
- (4) 其他途径包括社区筹资、主办方投入和社会捐赠等。

2.社区卫生服务的支付方式

(1) **供方支付**：医疗保险付费方对医疗服务提供方提供医疗服务所消耗的资源进行补偿。方式：

- ①对卫生服务机构：服务项目付费、按服务单元付费、按人头付费、按病种付费、按病种分值付费、总额预算制。
- ②对卫生服务提供者：薪金制、按绩效支付。

(2) **需方支付**：被保险人患病时，医疗保险机构对被保险人在接受医疗服务过程中医疗费用给予经济补偿，分担其疾病的经济风险。方式：起付线、共付、封顶线和混合支付。不同支付方式影响分配公平和效率；对卫生服务供需双方产生不同激励影响。

二、社区卫生服务的方式

- 1.以病人为中心的个体化服务。
- 2.以社区为导向的群体性基层医疗服务。
- 3.社区卫生服务的团队工作模式：解决病人健康问题为导向的基本医疗工作团队、促进人群健康和实施群体健康干预的公共卫生服务团队、社区卫生服务管理团队。

第十五章 社会卫生状况

第一节 概述

一、概念

- 1.**社会卫生状况 (social health status)**：人群健康状况，及影响人群健康的诸社会因素状况。
- 2.**人群健康状况**：是一个复杂的概念。按 WHO 对健康的定义，衡量人群健康应

社会医学研究社会病的主要内容:

- ❑ 社会病在人群中的发生率、发展变化规律和人群 分布特征。
- ❑ 社会病对个体和群体健康的影响, 其导致的经济 与社会负担。
- ❑ 导致社会病产生的根源, 特别是社会文化根源。
- ❑ 社会病的防控措施。

❑ 如果越轨行为影响了社会的稳定和发展, 就有可 能成为社会问题。

❑ 如果成为社会问题的越轨行为主要是由社会的原 因引起的, 而且与躯体和心理健康相关, 就构成 了所谓的“社会病”。

21.1 社会病概述

[概念] 概念释义: 社会病 (Sociopathy / Social Pathology): 由于社会原因 (社会制度、社会结构、社 会文化) 造成的, 与社会发展和进步方向相违背的、危害人群健康的社会性现象

辨析: 社会病与社会问题、越轨行为

- **社会问题 (Social Problem):** 广义上任何影响社会正常运行的问题, 社会病是社会问题中对人群健康影响最直接的一类 需要调动社会力量加以解决的 各种各样的问题。
- **越轨行为 (Deviant Behavior):** 偏离或违反社会规范的行为, 多数社会病涉及越轨行为, 但并非所有越轨行为都是社会病 从个人与社会的 关系角度来看, 凡是违背群体标准或期望的行为
- **反社会人格障碍 (Antisocial Personality Disorder):** 精神医学诊断, 主要表现为长期漠视和侵犯他人权利的行为模式, 与社会病概念不同但有一定交叉

21.1.1 社会病的特点 自杀, 非故意伤害, 成瘾行为, 攻击与暴力, 精神障碍, 性传播疾病

! 重点掌握: 社会病的五大特点:

- ❑ 社会病必须具有社会性
- ❑ 社会病的产生根源非常复杂, 但主要在于社会
- ❑ 社会病对社会具有严重的危害性 可能破坏社会稳定, 阻碍经济发展, 降低社会生活质量
- ❑ 社会病的防治需要全社会综合施策、共同努力
- ❑ 社会病既是社会问题, 也是健康问题或公共卫生 问题

21.2 攻击与暴力

21.2.1 基本概念

[概念] 概念释义: 攻击 (Aggression): 以伤害他人或损害物体为目的的行为。可以分为: 工具性攻击 (以达成某种目标为目的) 和敌意性攻击 (以伤害他人本身为目的)。

暴力 (Violence): 故意运用躯体力量或权力, 对自身、他人、群体或社会进行威胁或伤害, 造成或极有可能造成损伤、死亡、心理伤害、发育不良或剥夺的行为。

21.2.2 人际暴力 (教学难点 *)

! 重点掌握: (教学难点 *) 人际暴力 (Interpersonal Violence):

WHO 将暴力分为三大类:

1. **自我指向暴力 (Self-directed Violence):** 自杀行为 (自杀、自杀未遂、自杀意念)、自伤行为
2. **人际暴力 (Interpersonal Violence):** 家庭暴力/亲密伴侣暴力 (配偶虐待、儿童虐待、老年人虐待)、社区暴力 (熟人暴力和陌生人暴力)
3. **集体暴力 (Collective Violence):** 社会暴力、政治暴力、经济暴力

家庭暴力 (Domestic Violence) 的特点:

1. 建立国家自杀预防战略 自杀预防是一项系统工程。截止2014年，有28个国家建立自杀预防战略。
2. 提高人群的心理健康素质-普及心理卫生常识 -学校开设心理卫生课程，开展心理技能训练 -建立社区心理咨询和心理保健系统
3. 指导媒体有关自杀事件的报道WHO 提出应平衡报告自杀问题，积极宣传自杀预防知识，减少对自杀案例的渲染
4. 普及有关自杀和自杀预防的知识
5. 减少自杀的机会- 加强武器管理- 加强对有毒物质的管理- 加强对危险场所的防护和管理
6. 建立预防自杀的专门机构，自杀预防中心，危机干预中心，生命热线等
7. 对医务工作者和心理咨询工作者进行培训-提高自杀行为的识别能力-提高自杀救治能力
8. 提供完善的精神卫生服务，防治精神障碍:抑郁症、精神分裂症、酒瘾、药瘾
9. 加强学校和工作场所的自杀预防工作- 建立一个相对完整的心理卫生服务网络，及时发现和转诊可能处于自杀危险中的个体- 形成对有自杀危险性的个体的理解、关爱和支持 的氛围，降低对自杀行为的歧视，促使处于自杀危险中的个体积极寻求帮助
10. 关注自杀死亡者的亲人 关注心理调适和自杀预防

21.3 自杀

[概念] 概念释义：自杀 (Suicide)：个体在意识清晰的情况下，自愿地采取某种手段结束自己生命的行为。

自杀行为的分类：

1. 自杀意念 (Suicidal Ideation) ——有结束生命的想法但未付诸行动
2. 自杀未遂 (Attempted Suicide) ——实施了自杀行为但未导致死亡
3. 自杀死亡 (Completed Suicide) ——自杀行为导致死亡

→ 自杀计划 → 自杀预备

21.3.1 自杀的发生率与分布特征

！重点掌握：

- 全球：每年约 80 万人死于自杀（每 40 秒 1 人），自杀未遂人数约为自杀死亡人数的 20 倍
- 中国：曾经是全球自杀率最高的国家之一（1990 年代年自杀率约 23/10 万），近年来显著下降（约 7/10 万），这与社会经济发展和农药管理改善有关
- 中国自杀的独特模式：**农村显著高于城市**（3-5 倍，主要与农药可及性高有关）；老年人为最高风险人群；中国女性自杀率曾高于男性（全球大多数国家男性高于女性），近年已趋近国际模式
- 全球：自杀死亡以男性为主（男性: 女性 $\approx 3:1$ ），但自杀未遂以女性居多
- 高危人群：老年人、青少年（15-29 岁第二大死因）、精神障碍患者、LGBTQ 群体

21.3.2 自杀的社会根源

自杀的社会根源

自杀行为在个体层面上与个人性格、价值观念、人际关系、个人所遭受的社会心理压力、个人的应对方式、获得的社会支持以及精神、躯体健康状况等多种因素有密切关系。社会因素与自杀行为也息息相关。

1. 社会关系 迪尔凯姆根据一个团体或社会中社会整合的程度与社会规范对个人的影响:自我性自杀(整合程度低);利他性自杀(整合程度高);失范性自杀(社会规范弱)和宿命性自杀(社会规范强)。
2. 应激 自杀行为成为应对精神紧张、心理冲突的一种方式。
3. 文化 包括文化对自杀行为的态度;文化源性应激;社会文化变迁对社会关系、生活方式和个人行为产生重大影响。
4. 自杀手段的可及性
5. 医疗卫生服务及其可及性 可及的精神卫生服务 有可能预防精神障碍患者自杀;可及急救服务可以挽救死亡意愿非常强烈的自杀者的生命。

21.3.3 自杀的预防

1. 限制自杀工具和武器的可及性 2. 加强管理 3. 社会支持 4. 言语建设和言语防护

与自伤的区别和联系: [?] 自伤(self-injury):指在个人意识清楚的情况下，自愿地采取自我致伤、致残的行为，但完全没有结束自己生命的主观意愿。 [?] 自伤行为不是自杀行为，但可能自伤后得不到及时救治，也会导致死亡。 [?] 在自杀预防中，一般把自伤行为当做“准自杀行为”而给予重视

6. 综合性国家自杀预防战略——WHO 建议各国制定国家层面的自杀预防战略